



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

PANDUAN ASUHAN KEPERAWATAN

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada
Nomor : 722.1/I-PND/KPW/VIII/2025

Tentang
Panduan Asuhan Keperawatan

Disusun oleh :

Koordinator Rawat Inap



Very susanto, S.Kep, Ns

Disetujui oleh :

Authorized Person



Dr. dr. Aslichah, M. Kes, AFP

Ditetapkan oleh :

Direktur RS Prima Husada Malang.



dr. Nur Mazidah

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya Asuhan Keperawatan dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan RS. Prima Husada.

Asuhan Keperawatan ini yang mulai dipergunakan pada tahun 2025 meliputi sasaran keselamatan pasien, standar pelayanan berfokus pasien, standar manajemen rumah sakit, program nasional dan Integrasi pendidikan kesehatan dalam pelayanan di rumah sakit.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun yang telah berjuang untuk menyelesaikan standar ini dengan baik. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para kontributor yang telah memberikan masukan sangat berharga. Semoga dengan Asuhan Keperawatan ini, mutu pelayanan dan keselamatan pasien rumah sakit Prima Husada dapat lebih baik.

Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Nur Mazidah

TIM PENYUSUN

PANDUAN ASUHAN KEPERAWATAN

Pengarah

1. Dr. dr. Aslichah, M. Kes, AFP

Penyusun :

1. dr. Resti Lestantini, M. Kes
2. dr. Arief Heru Wicaksono, Sp. An
3. Puput Sekar, Amd. Keb
4. Sherly Rosita, Amd. Rosita
5. dr. Amanda Firmandani
6. Ns. Risma Indra Setiyani, S. Kep
7. Ns. Artika Wulandari, S. Kep
8. Very susanto, S.Kep, Ns

DAFTAR ASUHAN KEPERAWATAN

1. Appendisitis
2. Asma Bronkiale
3. Bayi Hiperbilirubinemi
4. BPH
5. Bronkhopneumoni
6. Chest Pain
7. CHF
8. CKD
9. CVA Haemorrhagic
10. CVA Nonhaemorrhagic
11. DHF
12. Hepatitis
13. Hipertensi
14. Infark Miokard Akut
15. Infeksi Saluran Kencing (ISK)
16. LBP
17. Typhoid Fever
18. Tonsilitis
19. Tumor Otak

**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG
NOMOR: 722.1/I-PND/KPW/VIII/2025**

**TENTANG
ASUHAN KEPERAWATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan asuhan keperawatan harus dilakukan sesuai dengan standar asuhan keperawatan yang disusun dalam asuhan keperawatan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan bagi Rumah Sakit dalam menyusun standar prosedur operasional perlu mengesahkan asuhan keperawatan yang disusun oleh Komite Keperawatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu adanya Peraturan Direktur tentang Asuhan Keperawatan
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Keselamatan Pasien;
5. Kepdirjen Nomor HK.01.07./MENKES/1596/.2024 tentang Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit;
6. Kepdirjen Nomor Hk.02.02/D/43961/2024 Tentang Pedoman survei Akreditasi Rumah Sakit
7. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 1042.92/DPMI-KEP/DIR/IX/2025 tentang Pengangkatan PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
TENTANG ASUHAN KEPERAWATAN**

-
- KESATU : Mengesahkan dan memberlakukan Pedoman Praktik Klinis sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.
- KEDUA : Asuhan Keperawatan merupakan pedoman bagi perawat sebagai pemberi asuhan pasien di Rumah Sakit Prima Husada.
- KETIGA : Asuhan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus dijadikan acuan dalam penyusunan standar prosedur operasional di Rumah Sakit Prima Husada
- KEEMPAT : Kepatuhan terhadap asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan memberikan pelayanan kesehatan dengan upaya terbaik
- KELIMA : Penyesuaian terhadap pelaksanaan asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dilakukan hanya berdasarkan keadaan tertentu yang memaksa untuk kepentingan pasien, dan dicatat dalam rekam medis.
- KEENAM : Komite keperawatan, Sub Komite Kredensial, Sub Komite Mutu Profesi, dan Sub Komite Etik dan Disiplin melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan asuhan keperawatan.
- KETUJUH : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 05 Agustus 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada,



dr. Nur Mazidah



APPENDISITIS

1. Pengertian (Definisi)	Appendisitis adalah inflamasi akut pada appendisitis vermiformis dan merupakan penyebab paling umum untuk bedah abdomen darurat (Brunner & Suddart, 1997)
2. Etiologi	Appendisitis tersumbat atau terlipat oleh: a. Fekalis/ massa keras dari feses b. Tumor, hiperplasia folikel limfoid c. Benda asing
3. Tanda dan gejala	a. Nyeri kuadran kanan bawah dan biasanya demam ringan b. Mual, muntah c. Anoreksia, malaise d. Nyeri tekan lokal pada titik Mc. Burney e. Spasme otot f. Konstipasi, diare (Brunner & Suddart, 1997)
4. Pemeriksaan Diagnostik	a. Sel darah putih : leukositosis diatas 12000/mm ³ , netrofil meningkat sampai 75% b. Urinalisis : normal, tetapi eritrosit/leukosit mungkin ada c. Foto abdomen: Adanya pergeseran material pada appendix (fekalis) ileus terlokalisir d. Tanda rovsing (+) : dengan melakukan palpasi kuadran bawah kiri yang secara paradoksial menyebabkan nyeri yang terasa di kuadran kanan bawah (Doenges, 1993; Brunner & Suddart, 1997)
5. Komplikasi	a. Komplikasi utama adalah perforasi appendix yang dapat berkembang menjadi peritonitis atau abses appendix b. Tromboflebitis supuratif c. Abses subfrenikus d. Obstruksi intestinal
6. Penatalaksanaan	a. Pembedahan diindikasikan bila diagnosa appendisitis telah ditegakkan b. Antibiotik dan cairan IV diberikan sampai pembedhan dilakukan c. Analgetik diberikan setelah diagnosa ditegakkan Apendektomi dilakukan sesegera mungkin untuk menurunkan resiko perforasi. (Brunner & Suddart, 1997)
7. Pengkajian	a. Aktivitas/ istirahat: Malaise b. Sirkulasi : Tachikardi c. Eliminasi i. Konstipasi pada awal ii. Diare (kadang-kadang) iii. Distensi abdomen iv. Nyeri tekan/lepas abdomen v. Penurunan bising usus d. Cairan/makanan : anoreksia, mual, muntah

	e. Kenyamanan f. Nyeri abdomen sekitar epigastrium dan umbilikus yang meningkat berat dan terlokalisasi pada titik Mc. Burney meningkat karena berjalan, bersin, batuk, atau nafas dalam g. Keamanan : demam h. Pernapasan b. Tachipnea c. Pernapasan dangkal (Brunner & Suddart, 1997)
8. Diagnosa keperawatan dan intervensi	1. Resiko tinggi terjadi infeksi b.d tidak adekuatnya pertahanan utama, perforasi, peritonitis sekunder terhadap proses inflamasi Tujuan : tidak terjadi infeksi Kriteria: • Penyembuhan luka berjalan baik • Tidak ada tanda infeksi seperti eritema, demam, drainase purulen • Tekanan darah >90/60 mmHg • Nadi < 100x/menit dengan pola dan kedalaman normal • Abdomen lunak, tidak ada distensi • Bising usus 5-34 x/menit Intervensi: a. Kaji dan catat kualitas, lokasi dan durasi nyeri. Waspada nyeri yang menjadi hebat b. Awasi dan catat tanda vital terhadap peningkatan suhu, nadi, adanya pernapasan cepat dan dangkal c. Kaji abdomen terhadap kekakuan dan distensi, penurunan bising usus d. Lakukan perawatan luka dengan tehnik aseptik e. Lihat insisi dan balutan. Catat karakteristik drainase luka/drain, eritema f. Kolaborasi: antibiotik Nyeri b.d distensi jaringan usus oleh onflamasi, adanya insisi bedah Kriteria hasil: Persepsi subyektif tentang nyeri menurun Tampak rileks Pasien dapat istirahat dengan cukup Intervensi: a. Kaji nyeri. Catat lokasi, karakteristik nyeri b. Pertahankan istirahat dengan posisi semi fowler c. Dorong untuk ambulasi dini d. Ajarkan tehnik untuk pernafasan diafragmatik lambat untuk membantu melepaskan otot yang tegang e. Hindari tekanan area popliteal f. Berikan antiemetik, analgetik sesuai program 3. Resiko tinggi kekurangan cairan tubuh b.d inflamasi peritoneum dengan cairan asing, muntah praoperasi, pembatasan pasca operasi Kriteria hasil; • Membran mukosa lembab • Turgor kulit baik • Haluaran urin adekuat: 1 cc/kg BB/jam • Tanda vital stabil

	Intervensi: - Awasi tekanan darah dan tanda vital - Kaji turgor kulit, membran mukosa, capillary refill - Monitor masukan dan haluaran . Catat warna urin/konsentrasi - Auskultasi bising usus. Catat kelancara flatus - Berikan perawatan mulut sering - Berikan sejumlah kecil minuman jernih bila pemasukan peroral dimulai dan lanjutkan dengan diet sesuai toleransi - Berikan cairan IV dan Elektrolit 4. Kurang pengetahuan tentang kondisi prognosis dan kebutuhan pengobatan b.d kurang informasi Kriteria: - Menyatakan pemahamannya tentang proses penyakit, pengobatan - Berpartisipasi dalam program pengobatan Intervensi - Kaji ulang embatasan aktivitas pasca operasi - Dorong aktivitas sesuai toleransi dengan periode istirahat periodik - Diskusikan perawatan insisi, termasuk mengganti balutan, pembatasan mandi - Identifikasi gejala yang memerlukan evaluasi medik, contoh peningkatan nyeri, edema/eritema luka, adanya drainase (Doenges, 1993)
--	---



ASMA BRONKIALE

1. Pengertian (Definisi)	Asma Bronkial adalah penyakit pernafasan obstruktif yang ditandai oleh spame akut otot polos bronkiolus. Hal ini menyebabkan obsktrusi aliran udara dan penurunan ventilasi alveolus.(Huddak & Gallo, 1997) Asma adalah penyakit jalan nafas obstruktif intermiten, reversibel dimana trakea dan bronchi berspon dalam secara hiperaktif terhadap stimuli tertentu.(Smeltzer, 2002 : 611) Asma adalah obstruksi jalan nafas yang bersifat reversibel, terjadi ketika bronkus mengalami inflamasi/peradangan dan hiperresponsif. (Reeves, 2001 : 48)
2. Etiologi	a. Faktor Ekstrinsik (asma imunologik / asma alergi) - Reaksi antigen-antibodi - Inhalasi alergen (debu, serbuk-serbuk, bulu-bulu binatang) b. Faktor Intrinsik (asma non imunologi / asma non alergi) - Infeksi : parainfluenza virus, pneumonia, mycoplasma - Fisik : cuaca dingin, perubahan temperatur - Iritan : kimia - Polusi udara : CO, asap rokok, parfum - Emosional : takut, cemas dan tegang - Aktivitas yang berlebihan juga dapat menjadi faktor pencetus. (Suriadi, 2001 : 7)
3. Tanda dan gejala	1. Stadium dini Faktor hipersekresi yang lebih menonjol a. Batuk dengan dahak bisa dengan maupun tanpa pilek b. Rochi basah halus pada serangan kedua atau ketiga, sifatnya hilang timbul c. Whezing belum ada d. Belum ada kelainan bentuk thorak e. Ada peningkatan eosinofil darah dan IG E f. BGA belum patologis Faktor spasme bronchiolus dan edema yang lebih dominan a. Timbul sesak napas dengan atau tanpa sputum b. Whezing c. Ronchi basah bila terdapat hipersekresi d. Penurunan tekanan parsial O₂ 2. Stadium lanjut/kronik a. Batuk, ronchi b. Sesak nafas berat dan dada seolah –olah tertekan c. Dahak lengket dan sulit untuk dikeluarkan d. Suara nafas melemah bahkan tak terdengar (silent Chest) e. Thorak seperti barel chest f. Tampak tarikan otot sternokleidomastoideus g. Sianosis h. BGA Pa O₂ kurang dari 80%

	i. Ro paru terdapat peningkatan gambaran bronchovaskuler kanan dan kiri j. Hipokapnea dan alkalosis bahkan asidosis respiratorik
4. Pemeriksaan penunjang	• Spirometri • Uji provokasi bronkus • Pemeriksaan sputum • Pemeriksaan eosinofil total • Uji kulit • Pemeriksaan kadar IgE total dan IgE spesifik dalam sputum • Foto dada • Analisis gas darah
5. Pengkajian keperawatan	1. Awitan distress pernafasan tiba-tiba 2. Perpanjangan ekspirasi mengi 3. Penggunaan otot-otot aksesori 4. Perpendekan periode inspirasi 5. Sesak nafas 6. Restraksi interkostal dan eksternal 7. Krekels 8. Bunyi nafas : mengi, menurun, tidak terdengar 9. Duduk dengan posisi tegak : bersandar kedepan 10. Diaforesis 11. Distensi vera leher 12. Sianosis : area sirkumoral, dasar kuku 13. Batuk keras, kering : batuk produktif sulit 14. Perubahan tingkat kesadaran 15. Hipokria 16. Hipotensi 17. Pulsus paradoksus > 10 mm 18. Dehidrasi 19. Peningkatan ansietas : takut menderita, takut mati
6. Diagnosa keperawatan	1. Tidak efektifnya bersihan jalan nafas b.d bronkospasme : peningkatan produksi sekret, sekresi tertahan, tebal, sekresi kental : penurunan energi/kelemahan 2. Kerusakan pertukaran gas b.d gangguan suplai oksigen, kerusakan alveoli 3. Perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh b.d penurunan masukan oral 4. Kurang pengetahuan b.d kurang informasi/tidak mengenal sumber informasi
7. Intervensi keperawatan	a. Aktivitas/ istirahat: Malaise b. Sirkulasi : Tachikardi c. Eliminasi i. Konstipasi pada awitan awal ii. Diare (kadang-kadang) iii. Distensi abdomen iv. Nyeri tekan/lepas abdomen v. Penurunan bising usus d. Cairan/makanan : anoreksia, mual, muntah e. Kenyamanan

	f. Nyeri abdomen sekitar epigastrium dan umbilikus yang meningkat berat dan terlokalisasi pada titik Mc. Burney meningkat karena berjalan, bersin, batuk, atau nafas dalam g. Keamanan : demam h. Pernapasan d. Tachipnea e. Pernapasan dangkal a. (Brunner & Suddart, 1997)
8. Diagnosa keperawatan dan intervensi	1. Tidak efektifnya bersihan jalan nafas Tujuan : Bersihan jalan nafas efektif Kriteria : - Mempertahankan jalan nafas paten dengan bunyi nafas bersih/jelas - Menunjukkan perilaku untuk memperbaiki bersihan jalan nafas mis : batuk efektif dan mengeluarkan sekret Intervensi: ➤ Auskultasi bunyi nafas, catat adanya bunyi nafas, mis; mengi, krekels, ronki ➤ Kaji/pantau frekuensi pernafasan ➤ Catat adanya/derajat diespnea mis : gelisah, ansietas, distress pernafasan, penggunaan otot bantu ➤ Kaji pasien untuk posisi yang nyaman mis : peninggian kepala tempat tidur, duduk pada sandaran tempat tidur ➤ Pertahankan polusi lingkungan minimum ➤ Dorong/bantu latihan nafas abdomen/bibir ➤ Observasi karakteristik batuk mis : menetap, batuk pendek, basah ➤ Tingkatkan masukan cairan sampai 3000 ml/hr ss toleransi jantung dan memberikan air hangat, anjurkan masukkan cairan sebagai ganti makanan ➤ Berikan obat sesuai indikasi ➤ Awasi/buat grafik seri GDA, nadi oksimetri, foto dada 2. Kerusakan pertukaran gas Tujuan : Pertukaran gas efektif dan adekuat Kriteria : -Menunjukkan perbaikan ventilasi dan oksigen jaringan adekuat dalam rentang normal dan bebas gejala distress pernafasan -Berpartisipasi dalam program pengobatan dalam tingkat kemampuan /situasi Intervensi: ➤ Kaji frekuensi, kedalaman pernafasan, catat penggunaan otot aksesori, nafas bibir, ketidak mampuan bicara/berbincang ➤ Tingguikan kepala tempat tidur, pasien untuk memilih posisi yang mudah untuk bernafas, dorong nafas dalam perlahan / nafas bibir sesuai kebutuhan / toleransi individu. ➤ Dorong mengeluarkan sputum : penguapan bila diindikasikan. ➤ Auskultasi bunyi nafas, catat area penurunan aliran udara dan / bunyi tambahan. ➤ Awasi tingkat kesadaran / status mental, selidiki adanya perubahan. ➤ Evaluasi tingkat toleransi aktivitas.

	➤ Awasi tanda vital dan irama jantung. ➤ Awasi / gambarkan seri GDA dan nadi oksimetri. ➤ Berikan oksigen yang sesuai idikasi hasil GDA dan toleransi pasien. 3. Perubahan nutrisi kurang dari tubuh Tujuan : Kebutuhan nutrisi terpenuhi Kriteria : - Menunjukkan peningkatan BB - Menunjukkan perilaku / perubahan pada hidup untuk meningkatkan dan / mempertahankan berat yang tepat. Intervensi : ➤ Kaji kebiasaan diet, masukan makanan, catat derajat kesulitan makan, evaluasi BB. ➤ Avskultasi bunyi usus. ➤ Berikan perawatan oral sering, buang sekret. ➤ Dorong periode istirahat, 1jam sebelum dan sesudah makan berikan makan porsi kecil tapi sering. ➤ Hindari makanan penghasil gas dan minuman karbonat. ➤ Hindari maknan yang sangat panas / dingin. ➤ Timbang BB sesuai induikasi. ➤ Kaji pemeriksaan laboratorium, ex : alb.serum. 4. Kurang pengetahuan Tujuan : Pengetahuan meningkat KH : - Menyatakan pemahaman kondisi / proses penyakit dan tindakan. - Mengidentifikasi hubungan tanda / gejala yang ada dari proses penyakit dan menghubungkan dengan faktor penyebab. - Melakukan perubahan pola hidup dan berpartisipasi dalam program pengobatan. Intervensi: ➤ Jelaskan proses penyakit individu dan keluarga ➤ Instrusikan untuk latihan nafas dan batuk efektif. ➤ Diskusikan tentang obat yang digunakan, efek samping, dan reaksi yang tidak diinginkan ➤ Beritahu tehnik penggunaan inhaler ct : cara memegang, interval semprotan, cara membersihkan. ➤ Tekankan pentingnya perawatan oral/kebersihan gigi ➤ Beritahu efek bahaya merokok dan nasehat untuk berhenti merokok pada klien atau orang terdekat ➤ Berikan informasi tentang pembatasan aktivitas.
--	--



BAYI HIPERBILIRUBINEMI

1. Pengertian (Definisi)	1. Ikterus Fisiologis Ikterus pada neonatus tidak selamanya patologis. Ikterus fisiologis adalah Ikterus yang memiliki karakteristik sebagai berikut (Hanifa, 1987): • Timbul pada hari kedua-ketiga • Kadar Bilirubin Indirek setelah 2 x 24 jam tidak melewati 15 mg% pada neonatus cukup bulan dan 10 mg % pada kurang bulan. • Kecepatan peningkatan kadar Bilirubin tak melebihi 5 mg % per hari • Kadar Bilirubin direk kurang dari 1 mg % • Ikterus hilang pada 10 hari pertama • Tidak terbukti mempunyai hubungan dengan keadaan patologis tertentu 2. Ikterus Patologis/Hiperbilirubinemia Adalah suatu keadaan dimana kadar Bilirubin dalam darah mencapai suatu nilai yang mempunyai potensi untuk menimbulkan Kern Ikterus kalau tidak ditanggulangi dengan baik, atau mempunyai hubungan dengan keadaan yang patologis. Brown menetapkan Hiperbilirubinemia bila kadar Bilirubin mencapai 12 mg% pada cukup bulan, dan 15 mg % pada bayi kurang bulan. Utelly menetapkan 10 mg% dan 15 mg%. 3. Kern Ikterus Adalah suatu kerusakan otak akibat perlengketan Bilirubin Indirek pada otak terutama pada Korpus Striatum, Talamus, Nukleus Subtalamus, Hipokampus, Nukleus merah , dan Nukleus pada dasar Ventrikulus IV.
2. Etiologi	1. Peningkatan produksi : • Hemolisis, misal pada Inkompatibilitas yang terjadi bila terdapat ketidaksesuaian golongan darah dan anak pada penggolongan Rhesus dan ABO. • Pendarahan tertutup misalnya pada trauma kelahiran. • Ikatan Bilirubin dengan protein terganggu seperti gangguan metabolik yang terdapat pada bayi Hipoksia atau Asidosis . • Defisiensi G6PD/ Glukosa 6 Phospat Dehidrogenase. • Ikterus ASI yang disebabkan oleh dikeluarkannya pregnan 3 (alfa), 20 (beta) , diol (steroid). • Kurangnya Enzim Glukoronil Transeferase , sehingga kadar Bilirubin Indirek meningkat misalnya pada berat lahir rendah. • Kelainan kongenital (Rotor Sindrome) dan Dubin

	Hiperbilirubinemia. 2. Gangguan transportasi akibat penurunan kapasitas pengangkutan misalnya pada Hipoalbuminemia atau karena pengaruh obat-obat tertentu misalnya Sulfadiazine. 3. Gangguan fungsi Hati yang disebabkan oleh beberapa mikroorganisme atau toksion yang dapat langsung merusak sel hati dan darah merah seperti Infeksi, Toksoplasmosis, Siphilis. 4. Gangguan ekskresi yang terjadi intra atau ekstra Hepatik. 5. Peningkatan sirkulasi Enterohepatik misalnya pada Ileus Obstruktif
3. Tanda dan gejala	1. Ikterus yang timbul pada 24 jam pertama. Penyebab Ikterus terjadi pada 24 jam pertama menurut besarnya kemungkinan dapat disusun sbb: • Inkompatibilitas darah Rh, ABO atau golongan lain. • Infeksi Intra Uterin (Virus, Toksoplasma, Siphilis dan kadang-kadang Bakteri) • Kadang-kadang oleh Defisiensi Enzim G6PD. Pemeriksaan yang perlu dilakukan: • Kadar Bilirubin Serum berkala. • Darah tepi lengkap. • Golongan darah ibu dan bayi. • Test Coombs. • Pemeriksaan skrining defisiensi G6PD, biakan darah atau biopsi Hepar bila perlu. 2. Ikterus yang timbul 24 - 72 jam sesudah lahir. • Biasanya Ikterus fisiologis. • Masih ada kemungkinan inkompatibilitas darah ABO atau Rh, atau golongan lain. Hal ini diduga kalau kenaikan kadar Bilirubin cepat misalnya melebihi 5mg% per 24 jam. • Defisiensi Enzim G6PD atau Enzim Eritrosit lain juga masih mungkin. • Polisetimia. • Hemolisis perdarahan tertutup (perdarahan subaponeurosis, perdarahan Hepar, sub kapsula dll). Bila keadaan bayi baik dan peningkatannya cepat maka pemeriksaan yang perlu dilakukan: • Pemeriksaan darah tepi. • Pemeriksaan darah Bilirubin berkala. • Pemeriksaan skrining Enzim G6PD. • Pemeriksaan lain bila perlu. 3. Ikterus yang timbul sesudah 72 jam pertama sampai akhir minggu pertama. • Sepsis. • Dehidrasi dan Asidosis. • Defisiensi Enzim G6PD. • Pengaruh obat-obat.

	• Sindroma Criggler-Najjar, Sindroma Gilbert. 4. Ikterus yang timbul pada akhir minggu pertama dan selanjutnya: • Karena ikterus obstruktif. • Hipotiroidisme • Breast milk Jaundice. • Infeksi. • Hepatitis Neonatal. • Galaktosemia. Pemeriksaan laboratorium yang perlu dilakukan: • Pemeriksaan Bilirubin berkala. • Pemeriksaan darah tepi. • Skrining Enzim G6PD. • Biakan darah, biopsi Hepar bila ada indikasi.
4. Pengkajian keperawatan	1. Riwayat orang tua : Ketidakseimbangan golongan darah ibu dan anak seperti Rh, ABO, Polisitemia, Infeksi, Hematoma, Obstruksi Pencernaan dan ASI. 2. Pemeriksaan Fisik : Kuning, Pallor Konvulsi, Letargi, Hipotonik, menangis melengking, refleks menyusui yang lemah, Iritabilitas. 3. Pengkajian Psikososial : Dampak sakit anak pada hubungan dengan orang tua, apakah orang tua merasa bersalah, masalah Bonding, perpisahan dengan anak. 4. Pengetahuan Keluarga meliputi : Penyebab penyakit dan pengobatan, perawatan lebih lanjut, apakah mengenal keluarga lain yang memiliki yang sama, tingkat pendidikan, kemampuan mempelajari Hiperbilirubinemia (Cindy Smith Greenberg. 1988)
5. Diagnosa dan intervensi keperawatan	1. Kurangnya volume cairan sehubungan dengan tidak adekuatnya intake cairan, fototerapi, dan diare. Tujuan : Cairan tubuh neonatus adekuat Intervensi : Catat jumlah dan kualitas feses, pantau turgor kulit, pantau intake output, beri air diantara menyusui atau memberi botol. 2. Gangguan suhu tubuh (hipertermi) sehubungan dengan efek fototerapi Tujuan : Kestabilan suhu tubuh bayi dapat dipertahankan Intervensi : Beri suhu lingkungan yang netral, pertahankan suhu antara 35,5° - 37° C, cek tanda-tanda vital tiap 2 jam. 3. Gangguan integritas kulit sehubungan dengan hiperbilirubinemia dan diare Tujuan : Keutuhan kulit bayi dapat dipertahankan Intervensi : Kaji warna kulit tiap 8 jam, pantau bilirubin direk dan indirek , rubah posisi setiap 2 jam, masase daerah yang menonjol, jaga kebersihan kulit dan kelembabannya. 4. Gangguan parenting sehubungan dengan pemisahan Tujuan : Orang tua dan bayi menunjukkan tingkah laku "Attachment" , orang tua dapat mengekspresikan ketidak mengertian proses Bounding. Intervensi : Bawa bayi ke ibu untuk disusui, buka tutup mata saat disusui, untuk stimulasi sosial dengan ibu, anjurkan orangtua untuk mengajak bicara anaknya, libatkan orang tua dalam perawatan bila memungkinkan, dorong orang tua mengekspresikan perasaannya. 5. Kecemasan meningkat sehubungan dengan terapi yang diberikan

	pada bayi. Tujuan : Orang tua mengerti tentang perawatan, dapat mengidentifikasi gejala-gejala untuk menyampaikan pada tim kesehatan. Intervensi : Kaji pengetahuan keluarga klien, beri pendidikan kesehatan penyebab dari kuning, proses terapi dan perawatannya. Beri pendidikan kesehatan mengenai cara perawatan bayi dirumah. 6. Potensial trauma sehubungan dengan efek fototerapi Tujuan : Neonatus akan berkembang tanpa disertai tanda-tanda gangguan akibat fototerapi Intervensi : Tempatkan neonatus pada jarak 45 cm dari sumber cahaya, biarkan neonatus dalam keadaan telanjang kecuali mata dan daerah genital serta bokong ditutup dengan kain yang dapat memantulkan cahaya; usahakan agar penutup mata tidak menutupi hidung dan bibir; matikan lampu, buka penutup mata untuk mengkaji adanya konjungtivitis tiap 8 jam; buka penutup mata setiap akan disusukan; ajak bicara dan beri sentuhan setiap memberikan perawatan. 7. Potensial trauma sehubungan dengan tranfusi tukar Tujuan : Tranfusi tukar dapat dilakukan tanpa komplikasi Intervensi : Catat kondisi umbilikal jika vena umbilikal yang digunakan; basahi umbilikal dengan NaCl selama 30 menit sebelum melakukan tindakan, neonatus puasa 4 jam sebelum tindakan, pertahankan suhu tubuh bayi, catat jenis darah ibu dan Rhesus serta darah yang akan ditranfusikan adalah darah segar; pantau tanda-tanda vital; selama dan sesudah tranfusi; siapkan suction bila diperlukan; amati adanya gangguan cairan dan elektrolit; apnoe, bradikardi, kejang; monitor pemeriksaan laboratorium sesuai program
--	---



BPH

1. Pengertian (Definisi)	a. Benigna Prostat Hiperplasi (BPH) adalah pembesaran jinak kelenjar prostat, disebabkan oleh karena hiperplasi beberapa atau semua komponen prostat meliputi jaringan kelenjar / jaringan fibromuskuler yang menyebabkan penyumbatan uretra pars prostatika (Lab / UPF Ilmu Bedah RSUD dr. Sutomo, 1994 : 193). b. BPH adalah pembesaran progresif dari kelenjar prostat (secara umum pada pria lebih tua dari 50 tahun) menyebabkan berbagai derajat obstruksi uretral dan pembatasan aliran urinarius (Marilynn, E.D, 2000 : 671).
2. Etiologi	Penyebab yang pasti dari terjadinya BPH sampai sekarang belum diketahui. Namun yang pasti kelenjar prostat sangat tergantung pada hormon androgen. Faktor lain yang erat kaitannya dengan BPH adalah proses penuaan Ada beberapa factor kemungkinan penyebab antara lain : 1). Dihydrotestosteron Peningkatan 5 alfa reduktase dan reseptor androgen menyebabkan epitel dan stroma dari kelenjar prostat mengalami hiperplasi . 2). Perubahan keseimbangan hormon estrogen - testoteron Pada proses penuaan pada pria terjadi peningkatan hormon estrogen dan penurunan testosteron yang mengakibatkan hiperplasi stroma. 3). Interaksi stroma - epitel Peningkatan epidermal growth factor atau fibroblast growth factor dan penurunan transforming growth factor beta menyebabkan hiperplasi stroma dan epitel. 4). Berkurangnya sel yang mati Estrogen yang meningkat menyebabkan peningkatan lama hidup stroma dan epitel dari kelenjar prostat. 5). Teori sel stem Sel stem yang meningkat mengakibatkan proliferasi sel transit (Roger Kirby, 1994 : 38).
3. Tanda dan gejala	Gejala klinis yang ditimbulkan oleh Benigne Prostat Hyperplasia disebut sebagai Syndroma Prostatisme. Syndroma Prostatisme dibagi menjadi dua yaitu : 1. Gejala Obstruktif yaitu : a. Hesitansi yaitu memulai kencing yang lama dan seringkali disertai dengan mengejan yang disebabkan oleh karena otot destrussor buli-buli memerlukan waktu beberapa lama meningkatkan tekanan intravesikal guna mengatasi adanya tekanan dalam uretra prostatika.

	b. Intermittency yaitu terputus-putusnya aliran kencing yang disebabkan karena ketidakmampuan otot destrussor dalam mempertahankan tekanan intra vesika sampai berakhirnya miksi. c. Terminal dribbling yaitu menetesnya urine pada akhir kencing. d. Pancaran lemah : kelemahan kekuatan dan kaliber pancaran destrussor memerlukan waktu untuk dapat melampaui tekanan di uretra. e. Rasa tidak puas setelah berakhirnya buang air kecil dan terasa belum puas. 2. Gejala Iritasi yaitu : a. Urgency yaitu perasaan ingin buang air kecil yang sulit ditahan. b. Frekuensi yaitu penderita miksi lebih sering dari biasanya dapat terjadi pada malam hari (Nocturia) dan pada siang hari. c. Disuria yaitu nyeri pada waktu kencing.
4. Diagnosa	Untuk menegakkan diagnosis BPH dilakukan beberapa cara antara lain 1). Anamnesa Kumpulan gejala pada BPH dikenal dengan LUTS (Lower Urinary Tract Symptoms) antara lain: hesitansi, pancaran urin lemah, intermittensi, terminal dribbling, terasa ada sisa setelah miksi disebut gejala obstruksi dan gejala iritatif dapat berupa urgensi, frekuensi serta disuria. 2) Pemeriksaan Fisik ▪ Dilakukan dengan pemeriksaan tekanan darah, nadi dan suhu. Nadi dapat meningkat pada keadaan kesakitan pada retensi urin akut, dehidrasi sampai syok pada retensi urin serta urosepsis sampai syok - septik. ▪ Pemeriksaan abdomen dilakukan dengan tehnik bimanual untuk mengetahui adanya hidronefrosis, dan pyelonefrosis. Pada daerah supra simfiser pada keadaan retensi akan menonjol. Saat palpasi terasa adanya ballotemen dan klien akan terasa ingin miksi. Perkusi dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya residual urin. ▪ Penis dan uretra untuk mendeteksi kemungkinan stenose meatus, striktur uretra, batu uretra, karsinoma maupun fimosis. ▪ Pemeriksaan skrotum untuk menentukan adanya epididimitis ▪ Rectal touch / pemeriksaan colok dubur bertujuan untuk menentukan konsistensi sistim persarafan unit vesiko uretra dan besarnya prostat. Dengan rectal toucher dapat diketahui derajat dari BPH, yaitu : - a). Derajat I = beratnya $\pm$ 20 gram. - b). Derajat II = beratnya antara 20 – 40 gram. - c). Derajat III = beratnya > 40 gram.
5. Pemeriksaan penunjang	1. Pemeriksaan Laboratorium 2. Pemeriksaan darah lengkap, faal ginjal, serum elektrolit dan

	kadar gula digunakan untuk memperoleh data dasar keadaan umum klien. 3. Pemeriksaan urin lengkap dan kultur. 4. PSA (Prostatik Spesific Antigen) penting diperiksa sebagai kewaspadaan adanya keganasan. 5. Pemeriksaan Uroflowmetri Salah satu gejala dari BPH adalah melemahnya pancaran urin. Secara obyektif pancaran urin dapat diperiksa dengan uroflowmeter dengan penilaian : - a). Flow rate maksimal $> 15 \text{ ml / dtk}$ = non obstruktif. - b). Flow rate maksimal $10 - 15 \text{ ml / dtk}$ = border line. - c). Flow rate maksimal $< 10 \text{ ml / dtk}$ = obstruktif. 6. Pemeriksaan Imaging dan Rontgenologik 7. BOF (Buik Overzicht) :Untuk melihat adanya batu dan metastase pada tulang. 8. USG (Ultrasonografi), digunakan untuk memeriksa konsistensi, volume dan besar prostat juga keadaan buli – buli termasuk residual urin. Pemeriksaan dapat dilakukan secara transrektal, transuretral dan supra pubik. 9. IVP (Pyelografi Intravena) Digunakan untuk melihat fungsi ekskresi ginjal dan adanya hidronefrosis. 10. Pemeriksaan Panendoskop Untuk mengetahui keadaan uretra dan buli – buli.
6. Pengkajian keperawatan	Modalitas terapi BPH adalah : 1). Observasi Yaitu pengawasan berkala pada klien setiap 3 – 6 bulan kemudian setiap tahun tergantung keadaan klien 2). Medikamentosa Terapi ini diindikasikan pada BPH dengan keluhan ringan, sedang, dan berat tanpa disertai penyulit. Obat yang digunakan berasal dari: fitoterapi (misalnya: Hipoxis rosperti, Serenoa repens, dll), gelombang alfa blocker dan golongan supresor androgen. 3). Pembedahan Indikasi pembedahan pada BPH adalah : - a). Klien yang mengalami retensi urin akut atau pernah retensi urin akut. - b). Klien dengan residual urin $> 100 \text{ ml}$. - c). Klien dengan penyulit. - d). Terapi medikamentosa tidak berhasil. - e). Flowmetri menunjukkan pola obstruktif. Pembedahan dapat dilakukan dengan : - a). TURP (Trans Uretral Reseksi Prostat $\rightarrow 90 - 95 \%$) - b). Retropubic Atau Extravesical Prostatectomy - c). Perianal Prostatectomy - d). Suprapubic Atau Tranvesical Prostatectomy 4). Alternatif lain (misalnya: Kriyoterapi, Hipertermia, Termoterapi, Terapi Ultrasonik .

7. Diagnosa keperawatan	Diagnosa keperawatan yang mungkin timbul adalah sebagai berikut : Pre Operasi : 1). Obstruksi akut / kronis berhubungan dengan obstruksi mekanik, pembesaran prostat, dekompensasi otot destrusor dan ketidakmampuan kandung kemih untuk berkontraksi secara adekuat. 2). Nyeri (akut) berhubungan dengan iritasi mukosa buli – buli, distensi kandung kemih, kolik ginjal, infeksi urinaria. 3). Resiko tinggi kekurangan cairan berhubungan dengan pasca obstruksi diuresis.. 4). Ansietas berhubungan dengan perubahan status kesehatan atau menghadapi prosedur bedah 5). Kurang pengetahuan tentang kondisi ,prognosis dan kebutuhan pengobatan berhubungan dengan kurangnya informasi Post Operasi : 1) Nyeri berhubungan dengan spasmus kandung kemih dan insisi sekunder pada TUR-P 2) Resiko tinggi infeksi berhubungan dengan prosedur invasif: alat selama pembedahan, kateter, irigasi kandung kemih sering. 3) Resiko tinggi cedera: perdarahan berhubungan dengan tindakan pembedahan 4) Resiko tinggi disfungsi seksual berhubungan dengan ketakutan akan impoten akibat dari TUR-P. 5) Kurang pengetahuan: tentang TUR-P berhubungan dengan kurang informasi 6) Gangguan pola tidur berhubungan dengan nyeri sebagai efek pembedahan
8. Intervensi keperawatan	Sebelum Operasi 1) Obstruksi akut / kronis berhubungan dengan obstruksi mekanik, pembesaran prostat, dekompensasi otot destrusor dan ketidakmampuan kandung kemih untuk berkontraksi secara adekuat. Tujuan : tidak terjadi obstruksi Kriteria hasil : Berkemih dalam jumlah yang cukup, tidak teraba distensi kandung kemih Rencana tindakan: a. Dorong pasien untuk berkemih tiap 2-4 jam dan bila tiba-tiba dirasakan. b. Observasi aliran urina perhatian ukuran dan kekuatan pancaran urina c. Awasi dan catat waktu serta jumlah setiap kali berkemih d. Berikan cairan sampai 3000 ml sehari dalam toleransi jantung. e. Berikan obat sesuai indikasi (antispasmodik) 2) Nyeri (akut) berhubungan dengan iritasi mukosa buli – buli, distensi kandung kemih, kolik ginjal, infeksi urinaria. Tujuan: Nyeri hilang / terkontrol. Kriteria hasil Klien melaporkan nyeri hilang / terkontrol, menunjukkan ketrampilan relaksasi dan aktivitas terapeutik sesuai indikasi untuk situasi individu. Tampak rileks, tidur / istirahat dengan tepat. Rencana tindakan:

	a. Kaji nyeri, perhatikan lokasi, intensitas (skala 0 - 10). b. Pertahankan patensi kateter dan sistem drainase. Pertahankan selang bebas dari lekukan dan bekuan. c. Pertahankan tirah baring bila diindikasikan d. Berikan tindakan kenyamanan (sentuhan terapeutik, pengubahan posisi, pijatan punggung) dan aktivitas terapeutik. e. Berikan rendam duduk atau lampu penghangat bila diindikasikan. f. Kolaborasi dalam pemberian antispasmodik 3) Resiko tinggi kekurangan cairan yang berhubungan dengan pasca obstruksi diuresis. Tujuan: Keseimbangan cairan tubuh tetap terpelihara. Kriteria hasil: Mempertahankan hidrasi adekuat dibuktikan dengan: tanda -tanda vital stabil, nadi perifer teraba, pengisian perifer baik, membran mukosa lembab dan keluaran urin tepat. Rencana tindakan: a. Awasi keluaran tiap jam bila diindikasikan. Perhatikan keluaran 100-200 ml/. b. Pantau masukan dan haluaran cairan. c. Awasi tanda-tanda vital, perhatikan peningkatan nadi dan pernapasan, penurunan tekanan darah, diaforesis, pucat, d. Tingkatkan tirah baring dengan kepala lebih tinggi e. Kolaborasi dalam memantau pemeriksaan laboratorium sesuai indikasi, contoh: Hb / Ht, jumlah sel darah merah. Pemeriksaan koagulasi, jumlah trombosi 4) Ansietas berhubungan dengan perubahan status kesehatan atau menghadapi prosedur bedah. Tujuan: Pasien tampak rileks. Kriteria hasil: Menyatakan pengetahuan yang akurat tentang situasi, menunjukkan rentang yang tepat tentang perasaan dan penurunan rasa takut. Rencana tindakan: a. Dampingi klien dan bina hubungan saling percaya b. Memberikan informasi tentang prosedur tindakan yang akan dilakukan. c. Dorong pasien atau orang terdekat untuk menyatakan masalah atau perasaan. 5) Kurang pengetahuan tentang kondisi ,prognosis dan kebutuhan pengobatan berhubungan dengan kurangnya informasi Tujuan : Menyatakan pemahaman tentang proses penyakit dan prognosinya. Kriteria hasil: Melakukan perubahan pola hidup atau prilasku ysnng perlu, berpartisipasi dalam program pengobatan. Rencana tindakan: a. Dorong pasien menyatakan rasa takut persaan dan perhatian. b. Kaji ulang proses penyakit pengalaman pasien Sesudah operasi: 1. Nyeri berhubungan dengan spasmus kandung kemih dan insisi sekunder pada TUR-P
--	--

	Tujuan: Nyeri berkurang atau hilang. Kriteria hasil: - Klien mengatakan nyeri berkurang / hilang. - Ekspresi wajah klien tenang. - Klien akan menunjukkan ketrampilan relaksasi. - Klien akan tidur / istirahat dengan tepat. - Tanda – tanda vital dalam batas normal. Rencana tindakan: - Jelaskan pada klien tentang gejala dini spasmus kandung kemih. - Pemantauan klien pada interval yang teratur selama 48 jam, untuk mengenal gejala – gejala dini dari spasmus kandung kemih. - Jelaskan pada klien bahwa intensitas dan frekuensi akan berkurang dalam 24 sampai 48 jam. - Beri penyuluhan pada klien agar tidak berkemih ke seputar kateter. - Anjurkan pada klien untuk tidak duduk dalam waktu yang lama sesudah tindakan TUR-P. - Ajarkan penggunaan teknik relaksasi, termasuk latihan nafas dalam, visualisasi. - Jagalah selang drainase urine tetap aman dipaha untuk mencegah peningkatan tekanan pada kandung kemih. Irigasi kateter jika terlihat bekuan pada selang. - Observasi tanda – tanda vital - Kolaborasi dengan dokter untuk memberi obat – obatan (analgesik atau anti spasmodik) 2. Resiko tinggi infeksi berhubungan dengan prosedur invasif: alat selama pembedahan, kateter, irigasi kandung kemih sering. Tujuan: Klien tidak menunjukkan tanda – tanda infeksi. Kriteria hasil: - Klien tidak mengalami infeksi. - Dapat mencapai waktu penyembuhan. - Tanda – tanda vital dalam batas normal dan tidak ada tanda – tanda shock. Rencana tindakan: - Pertahankan sistem kateter steril, berikan perawatan kateter dengan steril. - Anjurkan intake cairan yang cukup (2500 – 3000) sehingga dapat menurunkan potensial infeksi. - Pertahankan posisi urobag dibawah. - Observasi tanda – tanda vital, laporkan tanda – tanda shock dan demam. - Observasi urine: warna, jumlah, bau. - Kolaborasi dengan dokter untuk memberi obat antibiotik. 3. Resiko tinggi cedera: perdarahan berhubungan dengan tindakan pembedahan. Tujuan: Tidak terjadi perdarahan. Kriteria hasil: - Klien tidak menunjukkan tanda – tanda perdarahan . - Tanda – tanda vital dalam batas normal . - Urine lancar lewat kateter .
--	---

	Rencana tindakan: - Jelaskan pada klien tentang sebab terjadi perdarahan setelah pembedahan dan tanda – tanda perdarahan - Irigasi aliran kateter jika terdeteksi gumpalan dalam saluran kateter - Sediakan diet makanan tinggi serat dan memberi obat untuk memudahkan defekasi . - Mencegah pemakaian termometer rektal, pemeriksaan rektal atau huknah, untuk sekurang – kurangnya satu minggu . - Pantau traksi kateter: catat waktu traksi di pasang dan kapan traksi dilepas . - Observasi: Tanda – tanda vital tiap 4 jam, masukan dan haluaran dan warna urine 4. Resiko tinggi disfungsi seksual berhubungan dengan ketakutan akan impoten akibat dari TUR-P. Tujuan: Fungsi seksual dapat dipertahankan Kriteria hasil: - Klien tampak rileks dan melaporkan kecemasan menurun . - Klien menyatakan pemahaman situasi individual . - Klien menunjukkan keterampilan pemecahan masalah . - Klien mengerti tentang pengaruh TUR – P pada seksual. Rencana tindakan : - Beri kesempatan pada klien untuk memperbincangkan tentang pengaruh TUR – P terhadap seksual . - Jelaskan tentang : kemungkinan kembali ketingkat tinggi seperti semula dan kejadian ejakulasi retrograd (air kemih seperti susu) - Mencegah hubungan seksual 3-4 minggu setelah operasi . - Dorong klien untuk menanyakan kedokter selama di rawat di rumah sakit dan kunjungan lanjutan . 5. Kurang pengetahuan: tentang TUR-P berhubungan dengan kurang informasi Tujuan: Klien dapat menguraikan pantangan kegiatan serta kebutuhan berobat lanjutan . Kriteria hasil: - Klien akan melakukan perubahan perilaku. - Klien berpartisipasi dalam program pengobatan. - Klien akan mengatakan pemahaman pada pantangan kegiatan dan kebutuhan berobat lanjutan . Rencana tindakan: - Beri penjelasan untuk mencegah aktifitas berat selama 3-4 minggu. - Beri penjelasan untuk mencegah mencedakan waktu BAB selama 4-6 minggu; dan memakai pelumas tinja untuk laksatif sesuai kebutuhan. - Pemasukan cairan sekurang–kurangnya 2500-3000 ml/hari. - Anjurkan untuk berobat lanjutan pada dokter. - Kosongkan kandung kemih apabila kandung kemih sudah penuh .
--	---



BRONKHOPNEUMONIA

9. Pengertian (Definisi)	Pneumonia merupakan peradangan akut parenkim paru-paru yang biasanya berasal dari suatu infeksi. (Price, 1995) Pneumonia adalah peradangan yang mengenai parenkim paru, distal dari bronkiolus terminalis yang mencakup bronkiolus respiratorius, alveoli, serta menimbulkan konsolidasi jaringan paru dan menimbulkan gangguan pertukaran gas setempat. (Zul, 2001) Bronkopneumonia digunakan untuk menggambarkan pneumonia yang mempunyai pola penyebaran berbercak, teratur dalam satu atau lebih area terlokalisasi didalam bronki dan meluas ke parenkim paru yang berdekatan di sekitarnya. Pada bronkopneumonia terjadi konsolidasi area berbercak. (Smeltzer, 2001).
10. Etiologi	Bakteri Pneumonia bakteri biasanya didapatkan pada usia lanjut. Organisme gram positif seperti : <i>Streptococcus pneumoniae</i>, <i>S. aureus</i>, dan <i>Streptococcus pyogenes</i>. Bakteri gram negatif seperti <i>Haemophilus influenzae</i>, <i>Klebsiella pneumoniae</i> dan <i>P. Aeruginosa</i>. Virus Disebabkan oleh virus influenza yang menyebar melalui transmisi droplet. Cytomegalovirus dalam hal ini dikenal sebagai penyebab utama pneumonia virus. Jamur Infeksi yang disebabkan jamur seperti histoplasmosis menyebar melalui penghirupan udara yang mengandung spora dan biasanya ditemukan pada kotoran burung, tanah serta kompos. Protozoa Menimbulkan terjadinya <i>Pneumocystis carinii pneumonia</i> (CPC). Biasanya menjangkiti pasien yang mengalami immunosupresi. (Reeves, 2001)
11. Tanda dan gejala	- Kesulitan dan sakit pada saat pernafasan ☞ Nyeri pleuritik ☞ Nafas dangkal dan mendengkur ☞ Takipnea - Bunyi nafas di atas area yang mengalami konsolidasi ☞ Mengecil, kemudian menjadi hilang ☞ Krekels, ronki, egofoni - Gerakan dada tidak simetris - Menggigil dan demam 38,8 ° C sampai 41,1°C, delirium - Diafoesis - Anoreksia - Malaise - Batuk kental, produktif

	☞ Sputum kuning kehijauan kemudian berubah menjadi kemerahan atau berkarat 9. Gelisah 10. Sianosis ☞ Area sirkumoral ☞ Dasar kuku kebiruan 11. Masalah-masalah psikososial : disorientasi, ansietas, takut mati
12. Pemeriksaan penunjang	- Sinar x : mengidentifikasi distribusi struktural; dapat juga menyatakan abses luas/infiltrat, empiema(stapilococcus); infiltrasi menyebar atau terlokalisasi (bakterial); atau penyebaran /perluasan infiltrat nodul (virus). Pneumonia mikoplasma sinar x dada mungkin bersih. - GDA : tidak normal mungkin terjadi, tergantung pada luas paru yang terlibat dan penyakit paru yang ada. - Pemeriksaan gram/kultur sputum dan darah : diambil dengan biopsi jarum, aspirasi transtrakeal, bronkoskopifiberotik atau biopsi pembukaan paru untuk mengatasi organisme penyebab. - JDL : leukositosis biasanya ada, meski sel darah putih rendah terjadi pada infeksi virus, kondisi tekanan imun memungkinkan berkembangnya pneumonia bakterial. - Pemeriksaan serologi : titer virus atau legionella, aglutinin dingin. - LED : meningkat - Pemeriksaan fungsi paru : volume mungkin menurun (kongesti dan kolaps alveolar); tekanan jalan nafas mungkin meningkat dan komplain menurun, hipoksemia. - Elektrolit : natrium dan klorida mungkin rendah - Bilirubin : mungkin meningkat - Aspirasi perkutan/biopsi jaringan paru terbuka : menyatakan intranuklear tipikal dan keterlibatan sitoplasmik(CMV) (Doenges, 1999)
13. Pengkajian keperawatan	1. Aktivitas / istirahat Gejala : kelemahan, kelelahan, insomnia Tanda : Letargi, penurunan toleransi terhadap aktivitas 2. Sirkulasi Gejala : riwayat gagal jantung kronis Tanda : takikardi, penampilan keperawatan atau pucat 3. Integritas Ego Gejala : banyak stressor, masalah finansial 4. Makanan / Cairan Gejala : kehilangan nafsu makan, mual / muntah, riwayat DM Tanda : distensi abdomen, hiperaktif bunyi usus, kulit kering dengan turgor buruk, penampilan malnutrisi 5. Neurosensori Gejala : sakit kepala dengan frontal Tanda : perubahan mental 6. Nyeri / Kenyamanan Gejala : sakit kepala nyeri dada meningkat dan batuk myalgia, atralgia 7. Pernafasan Gejala : riwayat PPOM, merokok sigaret, takipnea, dispnea,

	pernafasan dangkal, penggunaan otot aksesori, pelebaran nasal Tanda : sputum merah muda, berkarat atau purulent Perkusi ; pekak diatas area yang konsolidasi, gesekan friksi pleural Bunyi nafas : menurun atau tak ada di atas area yang terlibat atau nafas Bronkial Framitus : taktil dan vokal meningkat dengan konsolidasi Warna : pucat atau sianosis bibir / kuku 8. Keamanan Gejala : riwayat gangguan sistem imun, demam Tanda : berkeringat, menggigil berulang, gemetar, kemerahan, mungkin pada kasus rubeda / varisela 9. Penyuluhan Gejala : riwayat mengalami pembedahan, penggunaan alkohol kronis
10. Diagnosa dan intervensi keperawatan	1. Kebersihan jalan nafas tidak efektif Dapat dihubungkan dengan : ➤ Inflamasi trakeobronkial, pembentukan oedema, peningkatan produksi sputum ➤ Nyeri pleuritik ➤ Penurunan energi, kelemahan Kriteria Hasil : ➤ Menunjukkan perilaku mencapai kebersihan jalan nafas ➤ Menunjukkan jalan nafas paten dengan bunyi nafas bersih, tak ada dispnea atau sianosis Intervensi : ➤ Mandiri ▪ Kali frekuensi / kedalaman pernafasan dan gerakan dada ▪ Auskultasi paru catat area penurunan / tak ada aliran udara dan bunyi nafas tambahan (krakles, mengi) ▪ Bantu pasien untuk batuk efektif dan nafas dalam ▪ Penghisapan sesuai indikasi ▪ Berikan cairan sedikitnya 2500 ml/hari ➤ Kolaborasi ▪ Bantu mengawasi efek pengobatan nebulizer dan fisioterapi lain ▪ Berikan obat sesuai indikasi : mukolitik, ekspektoran, bronkodilator, analgesik ▪ Berikan cairan tambahan ▪ Awasi seri sinar X dada, GDA, nadi oksimetri ▪ Bantu bronkoskopi / torakosintesis bila diindikasikan 2. Kerusakan pertukaran gas dapat dihubungkan dengan ➤ Perubahan membran alveolar – kapiler (efek inflamasi) ➤ Gangguan kapasitas oksigen darah Kriteria Hasil : ➤ Menunjukkan perbaikan ventilasi dan oksigenasi jaringan dengan GDA dalam rentang normal dan tak ada gejala distress pernafasan ➤ Berpartisipasi pada tindakan untuk memaksimalkan oksigen Intervensi : ➤ Mandiri ▪ Kaji frekuensi, kedalaman dan kemudahan bernafas

	▪ Observasi warna kulit, membran mukosa dan kuku ▪ Kaji status mental ▪ Awasi status jantung / irama ▪ Awasi suhu tubuh, sesuai indikasi. Bantu tindakan kenyamanan untuk menurunkan demam dan menggigil ▪ Pertahankan istirahat tidur ▪ Tinggikan kepala dan dorong sering mengubah posisi, nafas dalam dan batuk efektif ▪ Kaji tingkat ansietas. Dorong menyatakan masalah / perasaan. ➤ Kolaborasi ▪ Berikan terapi oksigen dengan benar ▪ Awasi GDA 3. Pola nafas tidak efektif Dapat dihubungkan dengan : ➤ Proses inflamasi ➤ Penurunan compliance paru ➤ Nyeri Kriteria Hasil : ➤ Menunjukkan pola pernafasan normal / efektif dengan GDA dalam rentang normal Intervensi : ➤ Mandiri ▪ Kaji frekuensi, kedalaman pernafasan dan ekspansi dada ▪ Auskultasi bunyi nafas ▪ Tinggikan kepala dan bantu mengubah posisi ▪ Observasi pola batuk dan karakter sekret ▪ Dorong / bantu pasien dalam nafas dalam dan latihan batuk efektif ➤ Kolaborasi ▪ Berikan Oksigen tambahan ▪ Awasi GDA 4. Peningkatan suhu tubuh Dapat dihubungkan : proses infeksi Kriteria Hasil : ➤ Pasien tidak memperlihatkan tanda peningkatan suhu tubuh ➤ Tidak menggigil ➤ Nadi normal Intervensi : ➤ Mandiri ▪ Observasi suhu tubuh (4 jam) ▪ Pantau warna kulit ▪ Lakukan tindakan pendinginan sesuai kebutuhan ➤ Kolaborasi ▪ Berikan obat sesuai indikasi : antiseptik ▪ Awasi kultur darah dan kultur sputum, pantau hasilnya setiap hari 5. Resiko tinggi penyebaran infeksi Dapat dihubungkan dengan : ➤ Ketidakadekuatan pertahanan utama
--	--

	➤ Tidak adekuat pertahanan sekunder (adanya infeksi, penekanan imun) Kriteria Hasil : ➤ Mencapai waktu perbaikan infeksi berulang tanpa komplikasi ➤ Mengidentifikasi intervensi untuk mencegah / menurunkan resiko infeksi Intervensi : ➤ Mandiri ▪ Pantau TTV ▪ Anjurkan klien memperhatikan pengeluaran sekret dan melaporkan perubahan warna jumlah dan bau sekret ▪ Dorong teknik mencuci tangan dengan baik ▪ Ubah posisi dengan sering ▪ Batasi pengunjung sesuai indikasi ▪ Lakukan isolasi pencegahan sesuai individu ▪ Dorong keseimbangan istirahat adekuat dengan aktivitas sedang. ➤ Kolaborasi ▪ Berikan antimikrobal sesuai indikasi 6. Intoleran aktivitas Dapat dihubungkan dengan ➤ Ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen ➤ Kelemahan, kelelahan Kriteria Hasil : ➤ Melaporkan / menunjukkan peningkatan toleransi terhadap aktivitas yang dapat diukur dengan tak adanya dispnea, kelemahan berlebihan dan TTV dalam rentang normal Intervensi : ➤ Mandiri ▪ Evaluasi respon klien terhadap aktivitas ▪ Berikan lingkungan terang dan batasi pengunjung ▪ Jelaskan pentingnya istirahat dalam rencana pengobatan dan perlunya keseimbangan aktivitas dan istirahat ▪ Bantu pasien memilih posisi yang nyaman untuk istirahat / tidur ▪ Bantu aktivitas perawatan diri yang diperlukan 7. Nyeri Dapat dihubungkan dengan : ➤ Inflamasi parenkim paru ➤ Reaksi seluler terhadap sirkulasi toksin ➤ Batuk menetap Kriteria Hasil : ➤ Menyebabkan nyeri hilang / terkontrol ➤ Menunjukkan rileks, istirahat / tidur dan peningkatan aktivitas dengan cepat Intervensi : ➤ Mandiri ▪ Tentukan karakteristik nyeri ▪ Pantau TTV ▪ Ajarkan teknik relaksasi
--	---

	▪ Anjurkan dan bantu pasien dalam teknik menekan dada selama episode batuk. 8. Resti nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh Dapat dihubungkan dengan : ➤ Peningkatan kebutuhan metabolik sekunder terhadap demam dan proses infeksi ➤ Anoreksia distensi abdomen Kriteria Hasil : ➤ Menunjukkan peningkatan nafsu makan ➤ Berat badan stabil atau meningkat Intervensi : ➤ Mandiri ▪ Identifikasi faktor yang menimbulkan mual atau muntah ▪ Berikan wadah tertutup untuk sputum dan buang sesering mungkin ▪ Auskultasi bunyi usus ▪ Berikan makan porsi kecil dan sering ▪ Evaluasi status nutrisi 9. Resti kekurangan volume cairan Faktor resiko : ➤ Kehilangan cairan berlebihan (demam, berkeringan banyak, hiperventilasi, muntah) Kriteria Hasil : ➤ Balance cairan seimbang ➤ Membran mukosa lembab, turgor normal, pengisian kapiler cepat Intervensi : ➤ Mandiri ▪ Kaji perubahan TTV ▪ Kaji turgor kulit, kelembaban membran mukosa ▪ Catat laporan mual / muntah ▪ Pantau masukan dan keluaran, catat warna, karakter urine ▪ Hitung keseimbangan cairan ▪ Asupan cairan minimal 2500 / hari ➤ Kolaborasi ▪ Berikan obat sesuai indikasi ; antipiretik, antiemetik ▪ Berikan cairan tambahan IV sesuai keperluan 10. Kurang pengetahuan mengenai kondisi dan kebutuhan tindakan Dapat dihubungkan dengan : ➤ Kurang terpajan informasi ➤ Kurang mengingat ➤ Kesalahan interpretasi Kriteria Hasil : ➤ Menyatakan pemahaman kondisi proses penyakit dan pengobatan ➤ Melakukan perubahan pola hidup Intervensi ➤ Mandiri ▪ Kaji fungsi normal paru ▪ Diskusikan aspek ketidakmampuan dari penyakit, lamanya penyembuhan dan harapan kesembuhan
--	---

	▪ Berikan dalam bentuk tertulis dan verbal ▪ Tekankan pentingnya melanjutkan batuk efektif ▪ Tekankan perlunya melanjutkan terapi antibiotik selama periode yang dianjurkan
--	---



CHEST PAIN

1. Pengertian (Definisi)	1. Nyeri dada adalah perasaan nyeri / tidak enak yang mengganggu daerah dada dan seringkali merupakan rasa nyeri yang diproyeksikan pada dinding dada (referred pain) 2. Nyeri Coroner adalah rasa sakit akibat terjadinya iskemik miokard karena suplai aliran darah koroner yang pada suatu saat tidak mencukupi untuk kebutuhan metabolisme miokard. 3. Nyeri dada akibat penyakit paru misalnya radang pleura (pleuritis) karena lapisan paru saja yang bisa merupakan sumber rasa sakit, sedang pleura viseralis dan parenkim paru tidak menimbulkan rasa sakit (Himawan, 1996)
2. Etiologi	Nyeri Dada: a. Cardial - Koroner - Non Koroner b. Non Cardial - Pleural - Gastrointestinal - Neural - Psikogenik (Abdurrahman N, 1999)
3. Tanda dan gejala	Tanda dan gejala yang biasa menyertai nyeri dada adalah : - Nyeri ulu hati - Sakit kepala - Nyeri yang diproyeksikan ke lengan, leher, punggung - Diaforesis / keringat dingin - Sesak nafas - Takikardi - Kulit pucat - Sulit tidur (insomnia) - Mual, Muntah, Anoreksia - Cemas, gelisah, fokus pada diri sendiri - Kelemahan - Wajah tegang, merintih, menangis - Perubahan kesadaran
4. Pemeriksaan penunjang	a. EKG 12 lead selama episode nyeri Takhikardi / disritmia Rekam EKG lengkap : T inverted, ST elevasi / depresi, Q Patologis b. Laboratorium Kadar enzim jantung : CK, CKMB, LDH Fungsi hati : SGOT, SGPT Fungsi Ginjal : Ureum, Creatinin Profil Lipid : LDL, HDL c. Foto Thorax d. Echocardiografi

	e. Kateterisasi jantung
5. Pengkajian keperawatan	1. Pengkajian Primer a. Airway - Bagaimana kepatenan jalan nafas - Apakah ada sumbatan / penumpukan sekret di jalan nafas? - Bagaimana bunyi nafasnya, apakah ada bunyi nafas tambahan? b. Breathing - Bagaimana pola nafasnya ? Frekuensinya? Kedalaman dan iramanya? - Apakah menggunakan otot bantu pernafasan? - Apakah ada bunyi nafas tambahan? c. Circulation - Bagaimana dengan nadi perifer dan nadi karotis? Kualitas (isi dan tegangan) - Bagaimana Capillary refillnya, apakah ada akral dingin, sianosis atau oliguri? - Apakah ada penurunan kesadaran? - Bagaimana tanda-tanda vitalnya ? T, S, N, RR, HR? 2. Pengkajian Sekunder Hal-hal penting yang perlu dikaji lebih jauh pada nyeri dada (koroner) : a. Lokasi nyeri Dimana tempat mulainya, penjarannya (nyeri dada koroner : mulai dari sternal menjalar ke leher, dagu atau bahu sampai lengan kiri bagian ulna) b. Sifat nyeri Perasaan penuh, rasa berat seperti kejang, meremas, menusuk, mencekik/rasa terbakar, dll. c. Ciri rasa nyeri Derajat nyeri, lamanya, berapa kali timbul dalam jangka waktu tertentu. d. Kronologis nyeri Awal timbul nyeri serta perkembangannya secara berurutan e. Keadaan pada waktu serangan Apakah timbul pada saat-saat / kondisi tertentu f. Faktor yang memperkuat / meringankan rasa nyeri misalnya sikap/posisi tubuh, pergerakan, tekanan, dll. g. Gejala lain yang mungkin ada atau tidaknya hubungan dengan nyeri dada.
6. Diagnosa keperawatan	1. Perubahan kenyamanan nyeri (nyeri akut) b.d iskemia jaringan sekunder terhadap sumbatan arteri, inflamasi jaringan 2. Perubahan perfusi jaringan (otot jantung) b.d penurunan aliran darah 3. Intoleransi aktivitas b.d ketidakseimbangan antara suplai O₂ dan kebutuhan metabolisme jaringan
7. Intervensi keperawatan	Prinsip-prinsip Tindakan : 1. Tirah baring (bedrest) dengan posisi fowler / semi fowler 2. Melakukan EKG 12 lead kalau perlu 24 lead 3. Mengobservasi tanda-tanda vital

	4. Kolaborasi pemberian O2 dan pemberian obat-obat analgesik, penenang, nitrogliserin, Calcium antagonis dan observasi efek samping obat. 5. Memasang infus dan memberi ketenangan pada klien 6. Mengambil sampel darah 7. Mengurangi rangsang lingkungan 8. Bersikap tenang dalam bekerja 9. Mengobservasi tanda-tanda komplikasi
--	--



CONGESTIVE HEART DISEASE

1. Pengertian (Definisi)	Gagal jantung kongestif / congestif heart failure (CHF) adalah ketidakmampuan jantung untuk memompa darah dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan jaringan terhadap oksigen dan nutrisi. (Diane C. Baughman dan Jo Ann C. Hockley, 2000) Suatu keadaan patofisiologi adanya kelainan fungsi jantung berakibat jantung gagal memompakan darah untuk memenuhi kebutuhan metabolisme jaringan dan atau kemampuannya hanya ada kalau disertai peninggian tekanan pengisian ventrikel kiri (Braundwald)
2. Etiologi	Gagal jantung kongestif dapat disebabkan oleh: ➤ Kelainan otot jantung Gagal jantung sering terjadi pada penderita kelainan otot jantung, disebabkan menurunnya kontraktilitas jantung. Kondisi yang mendasari penyebab kelainan fungsi otot mencakup aterosklerosis koroner, hipertensi arterial, dan penyakit degeneratif atau inflamasi. ➤ Aterosklerosis koroner mengakibatkan disfungsi miokardium karena terganggunya aliran darah ke otot jantung. Terjadi hipoksia dan asidosis (akibat penumpukan asam laktat). Infark miokardium (kematian sel jantung) biasanya mendahului terjadinya gagal jantung. Peradangan dan penyakit miokardium degeneratif, berhubungan dengan gagal jantung karena kondisi yang secara langsung merusak serabut jantung, menyebabkan kontraktilitas menurun. ➤ Hipertensi sistemik atau pulmonal (peningkatan afterload) meningkatkan beban kerja jantung dan pada gilirannya mengakibatkan hipertrofi serabut otot jantung ➤ Peradangan dan penyakit miokardium degeneratif, berhubungan dengan gagal jantung karena kondisi ini secara langsung merusak serabut jantung, menyebabkan kontraktilitas menurun. ➤ Penyakit jantung lain Gagal jantung dapat terjadi sebagai akibat penyakit jantung yang sebenarnya, yang secara langsung mempengaruhi jantung. Mekanisme biasanya terlibat mencakup gangguan aliran darah yang masuk jantung (stenosis katup semilunar), ketidakmampuan jantung untuk mengisi darah (tamponade, perikardium, perikarditis restriktif, atau stenosis AV), peningkatan mendadak after load. ➤ Faktor sistemik Terdapat sejumlah besar faktor yang berperan dalam perkembangan dan beratnya gagal jantung. Meningkatnya laju metabolisme (mis : demam, tirotoksikosis), hipoksia dan anemia memerlukan peningkatan curah jantung untuk memenuhi kebutuhan oksigen sistemik. Hipoksia dan anemia juga dapat menurunkan suplai oksigen ke jantung. Asidosis respiratorik atau metabolik dan abnormalitas elektronik dapat menurunkan kontraktilitas jantung

3. Tanda dan Gejala	Tanda dominan: Meningkatnya volume intravaskuler. Kongestif jaringan akibat tekanan arteri dan vena meningkat akibat penurunan curah jantung. Manifestasi kongesti dapat berbeda tergantung pada kegagalan ventrikel mana yang terjadi. • Gagal jantung kiri: Kongesti paru menonjol pada gagal ventrikel kiri krn ventrikel kiri tak mampu memompa darah yang datang dari paru. Manifestasi klinis yang terjadi yaitu : 1. Dispneu: Terjadi akibat penimbunan cairan dalam alveoli dan mengganggu pertukaran gas. Dapat terjadi ortopneu. Beberapa pasien dapat mengalami ortopneu pada malam hari yang dinamakan Paroksimal Nokturnal Dispnea (PND) 2. Batuk 3. Mudah Lelah: Terjadi karena curah jantung yang kurang yang menghambat jaringan dari sirkulasi normal dan oksigen serta menurunnya pembuangan sisa hasil katabolisme. Juga terjadi karena meningkatnya energi yang digunakan untuk bernafas dan insomnia yang terjadi karena distress pernafasan dan batuk. 4. Kegelisahan dan kecemasan: Terjadi akibat gangguan oksigenasi jaringan, stress akibat kesakitan bernafas dan pengetahuan bahwa jantung tidak berfungsi dengan baik. • Gagal jantung kanan 1. Kongestif jaringan perifer dan viseral. 2. Edema ekstremitas bawah (edema dependen), biasanya edema pitting, penambahan berat badan, 3. Hepatomegali. Dan nyeri tekan pada kuadran kanan atas abdomen terjadi akibat pembesaran vena di hepar... 4. Anorexia dan mual. Terjadi akibat pembesaran vena dan statis vena dalam rongga abdomen. 5. Nokturia 6. Kelemahan
4. Penatalaksanaan	Tujuan pengobatan adalah: ⇒ Dukung istirahat untuk mengurangi beban kerja jantung. ⇒ Meningkatkan kekuatan dan efisiensi kontraktilitas miokardium dengan preparat farmakologi, dan ⇒ Membuang penumpukan air tubuh yang berlebihan dengan cara memberikan terapi antidiuretik, diet dan istirahat. Terapi Farmakologis : □ Glikosida jantung. Digitalis, meningkatkan kekuatan kontraksi otot jantung dan memperlambat frekuensi jantung. Efek yang dihasilkan : peningkatan curah jantung, penurunan tekanan vena dan volume darah dan peningkatan diuresis dan mengurangi edema □ Terapi diuretik. Diberikan untuk memacu ekskresi natrium dan air melalui ginjal. Penggunaan hati-hati karena efek samping hiponatremia dan hipokalemia □ Terapi vasodilator. Obat-obat fenoaktif digunakan untuk mengurangi impedansi tekanan terhadap penyempitan darah oleh ventrikel. Obat ini memperbaiki

	pengosongan ventrikel dan peningkatan kapasitas vena sehingga tekanan engisian ventrikel kiri dapat diturunkan □ Dukungan diet: Pembatasan Natrium untuk mencegah, mengontrol, atau menghilangkan edema.
5. Pengkajian keperawatan	Fokus pengkajian keperawatan ditujukan untuk mngobservasi adanya tanda-tanda dan gejala kelebihan ciaran paru dan tanda serta gejala sistemis. 1. Aktivitas /istirahat Keletihan, insomnia, nyeri dada dengan ktifitas, gelisah, dispnea saat istirahat atau aktivitas, perubahan status mental, tanda vital berubah saat beraktivitas. 2. Sirkulasi Riwayat HT IM akut, GJK sebelumnya, penyakit katup jantung, anemia , syok dll TD, tekanan nadi frekuensi jantung, irama jantung, nadi apical bunyu jantung S3 galop nadi perifer bekurang perubahan dalam denyutan nadi jugularis warna kulit kebiruan punggung kuku pucat atau sianosis hepar adakag pembesaran bunyi nafas krekles atau ronkhi edema. 3. Inegritas ego Ansietas stress marah taku dan mudah tersinggung 4. Eliminasi Gejala penurunan berkemih urun berwarna pekat, berkemih malam hario diare/ konsipasi. 5. Makanan / cairan Kehilangan nafsu makan mual, muntah, penambahan Bbsignifikan, Pembengkakan ektrimitas bawah, diit tinggi garam penggunaan diuretic distensi abdomen edema umum dll. 6. Hygiene Keletihan selama aktivitas perawatan diri, penampilan kurang 7. Neurosensori Kelemahan, pusing letargi, perubahan perilaku dan mudah tersinggung 8. Nyeri/kenyamanan Nyeri dada akut kronuk nyeri abdomen sakit pada otot gelisah 9. Pernafasan keamanan Dispnea saat aktivitas tidur sambil duduk atau dngan beberapa bantal.btuk dengan atau tanpa sputum penggunaan bantuan otot pernafasan oksigen dll. Bunyi nafas warna kulit.
6. Diagnosa keperawatan dan intervensi	1. Penurunan perfusi jaringan berhubungan dngan menurunnya curah jantung , hipoksemia jaringan, asidosis, dan kemungkinan thrombus atau emboli Tujuan: Gangguan perfusi jaringan berkurang / tidak meluas selama dilakukan tindakan perawatan di RS. Kriteria : Daerah perifer hangat, tak sianosis, gambaran EKG tak menunjukan perluasan infark RR 16-24 x/ menit tak terdapat clubbing finger, kapiler refill 3-5 detik, nadi 60-100x / menit, TD 120/80 mmHg Rencana Tindakan :

	• Monitor Frekuensi dan irama jantung • Observasi perubahan status mental • Observasi warna dan suhu kulit / membran mukosa • Ukur haluaran urin dan catat berat jenisnya • Kolaborasi : Berikan cairan IV I sesuai indikasi • Pantau Pemeriksaan diagnostik / dan laboratorium mis EKG, elektrolit , GDA(Pa O₂, Pa CO₂ dan saturasi O₂). Dan Pemberian oksigen 2. Kerusakan pertukaran gas Dapat dihubungkan oleh : Gangguan aliran darah ke alveoli atau kegagalan utama paru, perubahan membran alveolar- kapiler (atelektasis , kolaps jalan nafas/ alveolar edema paru/efusi, sekresi berlebihan / perdarahan aktif. Tujuan : Oksigenasi dengan GDA dalam rentang normal (pa O₂ < 80 mmHg, pa Co₂ > 45 mmHg dan Saturasi < 80 mmHg) setelah dilakukan tindakan keperawatan selama di RS. Kriteria hasil : Tidak sesak nafas, tidak gelisah, GDA dala batas Normal (pa O₂ < 80 mmHg, pa Co₂ > 45 mmHg dan Saturasi < 80 mmHg) Tindakan : • Catat frekuensi & kedalaman pernafasan, penggunaan otot Bantu pernafasan • Auskultasi paru untuk mengetahui penurunan / tidak adanya bunyi nafas dan adanya bunyi tambahan missal krakles, ronki dll. • Lakukan tindakan untuk memperbaiki / mempertahankan jalan nafas misalnya , batuk, penghisapan lendir dll. • Tinggikan kepala / tempat tidur sesuai kebutuhan / toleransi pasien • Kaji toleransi aktifitas misalnya keluhan kelemahan/ kelelahan selama kerja atau tanda vital berubah. 3. Kemungkinan terhadap kelebihan volume cairan ekstrasvaskuler Faktor resiko meliputi : Penurunan perfusi ginjal, peningkatan natrium/ retensi air, peningkatan tekanan hidrostatik atau penurunan protein plasma (menyerap cairan dalam area interstisial/ jaringan) Tujuan : Keseimbangan volume cairan dapat dipertahankan selama dilakukan tindakan keperawatan selama di RS Kriteria : Mempertahankan keseimbangan cairan seperti dibuktikan oleh tekanan darah dalam batas normal, tak ada distensi vena perifer/ vena dan edema dependen, paru bersih dan berat badan ideal (BB idealTB – 100 ± 10 %) Tindakan : • Ukur masukan / haluaran, catat penurunan , pengeluaran, sifat konsentrasi, hitung keseimbangan cairan • Observasi adanya oedema dependen • Timbang BB tiap hari • Pertahankan masukan total cairan 2000 ml/24 jam dalam toleransi kardiovaskuler • Kolaborasi : pemberian diet rendah natrium, berikan diuetik.
--	--

	• Kaji JVP setelah terapi diuretic • Pantau CVP dan tekanan darah. 4. Pola nafas tidak efektif Yang berhubungan dengan : Penurunan volume paru, hepatomegali, splenomegali Tujuan : Pola nafas efektif setelah dilakukan tindakan keperawatan selama di RS, RR Normal , tak ada bunyi nafas tambahan dan penggunaan otot Bantu pernafasan. Dan GDA Normal. Interfensi : • Monitor kedalaman pernafasan, frekuensi, dan ekspansi dada. • Catat upaya pernafasan termasuk penggunaan otot Bantu nafas • Auskultasi bunyi nafas dan catat bila ada bunyi nafas tambahan • Tinggikan kepala dan Bantu untuk mencapai posisi yang nyaman mungkin. Kolaborasi pemberian Oksigen dan px GDA 5. Intoleransi aktifitas dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari Dapat dihubungkan dengan : ketidakseimbangan antar suplai oksigen miocard dan kebutuhan, adanya iskemik/ nekrotik jaringan miocard. Tujuan : Terjadi peningkatan toleransi pada klien setelah dilaksanakan tindakan keperawatan selama di RS Kriteria : frekuensi jantung 60-100 x/ menit dan TD 120-80 mmHg Rencana tindakan :: • Catat frekuensi jantung, irama, dan perubahan TD selama dan sesudah aktifitas • Tingkatkan istirahat (di tempat tidur) • Batasi aktifitas pada dasar nyeri dan berikan aktifitas sensori yang tidak berat. • Jelaskan pola peningkatan bertahap dari tingkat aktifitas, contoh bangun dari kursi bila tidak ada nyeri, ambulasi dan istirahat selama 1 jam setelah makan. • Kaji ulang tanda gangguan yang menunjukkan tidak toleran terhadap aktifitas atau memerlukan pelaporan pada dokter.
--	---



CRONIC KIDNEY DISEASE

1. Pengertian (Definisi)	Gagal ginjal kronik (GGK) biasanya akibat akhir dari kehilangan fungsi ginjal lanjut secara bertahap (Doenges, 1999; 626) Gagal ginjal kronis atau penyakit renal tahap akhir (ESRD) merupakan gangguan fungsi renal yang progresif dan irreversible dimana kemampuan tubuh gagal untuk mempertahankan metabolisme dan keseimbangan cairan dan elektrolit, menyebabkan uremia (retensi urea dan sampah nitrogen lain dalam darah). (Brunner & Suddarth, 2001; 1448) Gagal ginjal kronik merupakan perkembangan gagal ginjal yang progresif dan lambat, biasanya berlangsung beberapa tahun. (Price, 1992; 812)
2. Etiologi	1. Infeksi misalnya pielonefritis kronik, glomerulonefritis 2. Penyakit vaskuler hipertensif misalnya nefrosklerosis benigna, nefrosklerosis maligna, stenosis arteria renalis 3. Gangguan jaringan penyambung misalnya lupus eritematosus sistemik, poliarteritis nodosa, sklerosis sistemik progresif 4. Gangguan kongenital dan hereditas misalnya penyakit ginjal polikistik, asidosis tubulus ginjal 5. Penyakit metabolik misalnya DM, gout, hiperparatiroidisme, amiloidosis 6. Nefropati toksik misalnya penyalahgunaan analgesik, nefropati timbal 7. Nefropati obstruktif misalnya saluran kemih bagian atas: kalkuli neoplasma, fibrosis retroperitoneal. Saluran kemih bagian bawah: hipertropi prostat, striktur uretra, anomali kongenital pada leher kandung kemih dan uretra. 8. Batu saluran kencing yang menyebabkan hidrolitiasis
9. Tanda dan gejala	1. Manifestasi klinik antara lain (Long, 1996 : 369): a. Gejala dini : lethargi, sakit kepala, kelelahan fisik dan mental, berat badan berkurang, mudah tersinggung, depresi b. Gejala yang lebih lanjut : anoreksia, mual disertai muntah, nafas dangkal atau sesak nafas baik waktu ada kegiatan atau tidak, udem yang disertai lekukan, pruritis mungkin tidak ada tapi mungkin juga sangat parah. 2. Manifestasi klinik menurut (Smeltzer, 2001 : 1449) antara lain : hipertensi, (akibat retensi cairan dan natrium dari aktivitas sistem renin - angiotensin – aldosteron), gagal jantung kongestif dan udem pulmoner (akibat cairan berlebihan) dan perikarditis (akibat iritasi pada lapisan perikardial oleh toksik, pruritis, anoreksia, mual, muntah, dan cegukan, kedutan otot, kejang, perubahan tingkat kesadaran, tidak mampu berkonsentrasi). 3. Manifestasi klinik menurut Suyono (2001) adalah sebagai berikut: a. Gangguan kardiovaskuler Hipertensi, nyeri dada, dan sesak nafas akibat perikarditis, effusi perikardiac dan gagal jantung akibat penimbunan cairan,

	gangguan irama jantung dan edema. b. Gangguan Pulmoner Nafas dangkal, kussmaul, batuk dengan sputum kental dan riak, suara krekels. c. Gangguan gastrointestinal Anoreksia, nausea, dan vomitus yang berhubungan dengan metabolisme protein dalam usus, perdarahan pada saluran gastrointestinal, ulserasi dan perdarahan mulut, nafas bau ammonia. d. Gangguan muskuloskeletal Resiles leg sindrom (pegal pada kakinya sehingga selalu digerakan), burning feet syndrom (rasa kesemutan dan terbakar, terutama ditelapak kaki), tremor, miopati (kelemahan dan hipertropi otot – otot ekstremitas. e. Gangguan Integumen kulit berwarna pucat akibat anemia dan kekuning – kuning akibat penimbunan urokrom, gatal – gatal akibat toksik, kuku tipis dan rapuh. f. Gangguan endokrin g. Gangguan seksual : libido fertilitas dan ereksi menurun, gangguan menstruasi dan aminore. Gangguan metabolic glukosa, gangguan metabolic lemak dan vitamin D. h. Gangguan cairan elektrolit dan keseimbangan asam dan basa: biasanya retensi garam dan air tetapi dapat juga terjadi kehilangan natrium dan dehidrasi, asidosis, hiperkalemia, hipomagnesemia, hipokalsemia. i. System hematologi: anemia yang disebabkan karena berkurangnya produksi eritopoetin, sehingga rangsangan eritopoesis pada sum – sum tulang berkurang, hemolisis akibat berkurangnya masa hidup eritrosit dalam suasana uremia toksik, dapat juga terjadi gangguan fungsi trombosis dan trombositopeni.
10. Pemeriksaan penunjang	Didalam memberikan pelayanan keperawatan terutama intervensi maka perlu pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan baik secara medis ataupun kolaborasi antara lain : 1. Pemeriksaan lab.darah - hematologi Hb, Ht, Eritrosit, Lekosit, Trombosit - RFT (renal fungsi test) ureum dan kreatinin - LFT (liver fungsi test) - Elektrolit Klorida, kalium, kalsium - koagulasi studi PTT, PTTK - BGA 2. Urine - urine rutin - urin khusus : benda keton, analisa kristal batu 3. pemeriksaan kardiovaskuler - ECG - ECO

	4. Radidiagnostik - USG abdominal - CT scan abdominal - BNO/IVP, FPA - Renogram - RPG (retio pielografi)
11. Penatalaksanaan	Penatalaksanaan keperawatan pada pasien dengan CKD dibagi tiga yaitu : a) Konservatif Dilakukan pemeriksaan lab.darah dan urin Observasi balance cairan Observasi adanya odema Batasi cairan yang masuk b) Dialysis Peritoneal dialysis biasanya dilakukan pada kasus – kasus emergency. Sedangkan dialysis yang bisa dilakukan dimana saja yang tidak bersifat akut adalah CAPD (Continues Ambulatori Peritonal Dialysis) Hemodialisis Yaitu dialisis yang dilakukan melalui tindakan infasif di vena dengan menggunakan mesin. Pada awalnya hemodiliasis dilakukan melalui daerah femoralis namun untuk mempermudah maka dilakukan : - AV fistule : menggabungkan vena dan arteri - Double lumen : langsung pada daerah jantung (vaskularisasi ke jantung) c) Operasi - Pengambilan batu - transplantasi ginjal
12. Pengkajian keperawatan	a. Aktifitas dan Istirahat: Kelelahan, kelemahan, malaise, gangguan tidur, kelemahan otot dan tonus, penurunan ROM b. Sirkulasi: Riwayat hipertensi lama atau berat, palpitasi, nyeri dada, peningkatan JVP, tachycardia, hipotensi orthostatic, friction rub. c. Integritas Ego: Faktor stress, perasaan tak berdaya, tak ada kekuatan, menolak, cemas, takut, marah, irritable d. Eliminasi: Penurunan frekuensi urin, oliguri, anuri, perubahan warna urin, urin pekat warna merah/coklat, berawan, diare, konstipasi, abdomen kembung e. Makanan/Cairan: Peningkatan BB karena edema, penurunan BB karena malnutrisi, anoreksia, mual, muntah, rasa logam pada mulut, asites, penurunan otot, penurunan lemak subkutan. f. Neurosensori: Sakit kepala, penglihatan kabur, kram otot, kejang, kebas, kesemutan, gangguan status mental,penurunan lapang perhatian, ketidakmampuan berkonsentrasi, kehilangan memori, kacau, penurunan tingkat kesadaran, koma g. Nyeri/Kenyamanan: Nyeri panggul, sakit kepala, kram otot, nyeri kaki, distraksi, gelisah h. Pernafasan: Pernafasan kusmaul (cepat dan dangkal), paroksismal nokturnal dyspnea (+), batuk produktif dengan frothy sputum bila terjadi edema pulmonal.

	i. Keamanan: Kulit gatal, infeksi berulang, pruritus, demam (sepsis dan dehidrasi), petekie, ekimosis, fraktur tulang, deposit fosfat kalsium pada kulit, ROM terbatas. j. Seksualitas: Penurunan libido, amenore, infertilitas k. Interaksi Sosial: Tidak mampu bekerja, tidak mampu menjalankan peran seperti biasanya (Doenges, 2000)
13. Diagnosa keperawatan	Menurut Doenges (1999) dan Lynda Juall (2000), diagnosa keperawatan yang muncul pada pasien CKD adalah: 1. Penurunan curah jantung 2. Gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit 3. Perubahan nutrisi 4. Perubahan pola nafas 5. Gangguan perfusi jaringan 6. Intoleransi aktivitas 7. Kurang pengetahuan tentang tindakan medis 8. Restri terjadinya infeksi
14. Intervensi keperawatan	1. Penurunan curah jantung berhubungan dengan beban jantung yang meningkat Tujuan: Penurunan curah jantung tidak terjadi dengan kriteria hasil : mempertahankan curah jantung dengan bukti tekanan darah dan frekuensi jantung dalam batas normal, nadi perifer kuat dan sama dengan waktu pengisian kapiler Intervensi: - Auskultasi bunyi jantung dan paru - Kaji adanya hipertensi - Selidiki keluhan nyeri dada, perhatikan lokasi, rediasi, beratnya (skala 0-10) - Kaji tingkat aktivitas, respon terhadap aktivitas 2. Gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit berhubungan dengan edema sekunder : volume cairan tidak seimbang oleh karena retensi Na dan H₂O). Tujuan: Mempertahankan berat tubuh ideal tanpa kelebihan cairan dengan kriteria hasil: tidak ada edema, keseimbangan antara input dan output. Intervensi : - Kaji status cairan dengan menimbang BB perhari, keseimbangan masukan dan haluaran, turgor kulit tanda-tanda vital - Batasi masukan cairan Jelaskan pada pasien dan keluarga tentang pembatasan cairan - Anjurkan pasien / ajari pasien untuk mencatat penggunaan cairan terutama pemasukan dan haluaran 3. Perubahan nutrisi: kurang dari kebutuhan berhubungan dengan anoreksia, mual, muntah Tujuan: Mempertahankan masukan nutrisi yang adekuat dengan kriteria hasil: menunjukkan BB stabil Intervensi: - Awasi konsumsi makanan / cairan - Perhatikan adanya mual dan muntah - Berikan makanan sedikit tapi sering

	- Tingkatkan kunjungan oleh orang terdekat selama makan - Berikan perawatan mulut sering 4. Perubahan pola nafas berhubungan dengan hiperventilasi sekunder: kompensasi melalui alkalosis respiratorik Tujuan: Pola nafas kembali normal / stabil Intervensi: - Auskultasi bunyi nafas, catat adanya crackles - Ajarkan pasien batuk efektif dan nafas dalam - Atur posisi senyaman mungkin - Batasi untuk beraktivitas 5. Kerusakan integritas kulit berhubungan dengan pruritis Tujuan: Integritas kulit dapat terjaga dengan kriteria hasil : Mempertahankan kulit utuh Menunjukkan perilaku / teknik untuk mencegah kerusakan kulit Intervensi: a. Inspeksi kulit terhadap perubahan warna, turgor, vaskuler, perhatikan kadanya kemerahan b. Pantau masukan cairan dan hidrasi kulit dan membran mukosa c. Inspeksi area tergantung terhadap udem d. Ubah posisi sesering mungkin e. Berikan perawatan kulit f. Pertahankan linen kering g. Anjurkan pasien menggunakan kompres lembab dan dingin untuk memberikan tekanan pada area pruritis h. Anjurkan memakai pakaian katun longgar 6. Intoleransi aktivitas berhubungan dengan oksigenasi jaringan yang tidak adekuat, kelelahan Tujuan: Pasien dapat meningkatkan aktivitas yang dapat ditoleransi Intervensi: a. Pantau pasien untuk melakukan aktivitas b. Kaji faktor yang menyebabkan kelelahan c. Anjurkan aktivitas alternatif sambil istirahat d. Pertahankan status nutrisi yang adekuat 7. Kurang pengetahuan tentang kondisi, prognosis dan tindakan medis (hemodialisa) b.d salah interpretasi informasi. - Kaji ulang penyakit/prognosis dan kemungkinan yang akan dialami. - Beri pendidikan kesehatan mengenai pengertian, penyebab, tanda dan gejala CKD serta penatalaksanaannya (tindakan hemodialisa). - Libatkan keluarga dalam memberikan tindakan. - Anjurkan keluarga untuk memberikan support system. - Evaluasi pasien dan keluarga setelah diberikan penkes.
--	---



CVA HAEMORRHAGIC

1. Pengertian (Definisi)	Gangguan peredaran darah di otak (GPDO) atau dikenal dengan CVA (Cerebro Vaskuar Accident) adalah gangguan fungsi syaraf yang disebabkan oleh gangguan aliran darah dalam otak yang dapat timbul secara mendadak (dalam beberapa detik) atau secara cepat (dalam beberapa jam) dengan gejala atau tanda yang sesuai dengan daerah yang terganggu.(Harsono,1996, hal 67)
2. Etiologi	Penyebab-penyebabnya antara lain: 1. Trombosis (bekuan cairan di dalam pembuluh darah otak) 2. Embolisme cerebral (bekuan darah atau material lain) 3. Iskemia (Penurunan aliran darah ke area otak) (Smeltzer C. Suzanne, 2002, hal 2131)
3. Tanda dan gejala	Berdasarkan lokasinya di tubuh, gejala-gejala Stroke terbagi menjadi berikut: 1. Bagian sistem saraf pusat : Kelemahan otot (hemiplegia), kaku, menurunnya fungsi sensorik. 2. Batang otak, dimana terdapat 12 saraf kranial: menurun kemampuan membau, mengecap, mendengar, dan melihat parsial atau keseluruhan, refleks menurun, ekspresi wajah terganggu, pernafasan dan detak jantung terganggu, lidah lemah. 3. Cerebral cortex: aphasia, apraxia, daya ingat menurun, hemineglect, kebingungan. Jika tanda-tanda dan gejala tersebut hilang dalam waktu 24 jam, dinyatakan sebagai Transient Ischemic Attack (TIA), dimana merupakan serangan kecil atau serangan awal Stroke.
4. Pemeriksaan penunjang	a. CT Scan: Memperlihatkan adanya edema, hematoma, iskemia dan adanya infark b. Angiografi serebral: membantu menentukan penyebab stroke secara spesifik seperti perdarahan atau obstruksi arteri c. Pungsi Lumbal: menunjukkan adanya tekanan normal, tekanan meningkat dan cairan yang mengandung darah menunjukkan adanya perdarahan d. MRI: Menunjukkan daerah yang mengalami infark, hemoragik. e. EEG: Memperlihatkan daerah lesi yang spesifik f. Ultrasonografi Dopler: Mengidentifikasi penyakit arteriovena g. Sinar X Tengkorak: Menggambarkan perubahan kelenjar lempeng pineal (DoengesE, Marilyn,2000 hal 292)
5. Pengkajian keperawatan	1. Aktivitas dan istirahat: Data Subyektif: - kesulitan dalam beraktivitas; kelemahan, kehilangan sensasi atau paralysis. - mudah lelah, kesulitan istirahat (nyeri atau kejang otot) Data obyektif:

	- Perubahan tingkat kesadaran - Perubahan tonus otot (flaksid atau spastic), paraliysis (hemiplegia), kelemahan umum. - gangguan penglihatan 2. Sirkulasi Data Subyektif: - Riwayat penyakit jantung (penyakit katup jantung, disritmia, gagal jantung, endokarditis bacterial), polisitemia. Data obyektif: - Hipertensi arterial - Disritmia, perubahan EKG - Pulsasi: kemungkinan bervariasi - Denyut karotis, femoral dan arteri iliaka atau aorta abdominal 3. Integritas ego Data Subyektif: - Perasaan tidak berdaya, hilang harapan Data obyektif: - Emosi yang labil dan marah yang tidak tepat, kesedihan, kegembiraan - kesulitan berekspresi diri 4. Eliminasi Data Subyektif: - Inkontinensia, anuria - distensi abdomen (kandung kemih sangat penuh), tidak adanya suara usus(ileus paralitik) 5. Makan/ minum Data Subyektif: - Nafsu makan hilang - Nausea / vomitus menandakan adanya PTIK - Kehilangan sensasi lidah, pipi, tenggorokan, disfagia - Riwayat DM, Peningkatan lemak dalam darah Data obyektif: - Problem dalam mengunyah (menurunnya reflek palatum dan faring) - Obesitas (factor resiko) 6. Sensori neural Data Subyektif: - Pusing / syncope (sebelum CVA / sementara selama TIA) - nyeri kepala : pada perdarahan intra serebral atau perdarahan sub arachnoid. - Kelemahan, kesemutan/kebas, sisi yang terkena terlihat seperti lumpuh/mati - Penglihatan berkurang - Sentuhan : kehilangan sensor pada sisi kolateral pada ekstremitas dan pada muka ipsilateral (sisi yang sama) - Gangguan rasa pengecap dan penciuman Data obyektif: - Status mental ; koma biasanya menandai stadium perdarahan , gangguan tingkah laku (seperti: letergi, apatis, menyerang) dan gangguan fungsi kognitif
--	---

	- Ekstremitas : kelemahan / paralisis (kontralateral pada semua jenis stroke, genggaman tangan tidak imbang, berkurangnya reflek tendon dalam (kontralateral) - Wajah: paralisis / parese (ipsilateral) - Afasia (kerusakan atau kehilangan fungsi bahasa, kemungkinan ekspresif/ kesulitan berkata kata, reseptif / kesulitan berkata kata komprehensif, global / kombinasi dari keduanya. - Kehilangan kemampuan mengenal atau melihat, pendengaran, stimuli taktil - Apraksia : kehilangan kemampuan menggunakan motorik - Reaksi dan ukuran pupil : tidak sama dilatasi dan tak bereaksi pada sisi ipsi lateral 7. Nyeri / kenyamanan Data Subyektif: - Sakit kepala yang bervariasi intensitasnya Data obyektif: - Tingkah laku yang tidak stabil, gelisah, ketegangan otot / fasial 8. Respirasi Data Subyektif: - Perokok (factor resiko) Tanda: - Kelemahan menelan/ batuk/ melindungi jalan napas - Timbulnya pernapasan yang sulit dan / atau tak teratur - Suara nafas terdengar ronchi /aspirasi 9.Keamanan Data obyektif: - Motrik/sensorik : masalah dengan penglihatan - Perubahan persepsi terhadap tubuh, kesulitan untuk melihat objek, hilang kewasadaan terhadap bagian tubuh yang sakit - Tidak mampu mengenali objek, warna, kata, dan wajah yang pernah dikenali - Gangguan berespon terhadap panas, dan dingin/gangguan regulasi suhu tubuh - Gangguan dalam memutuskan, perhatian sedikit terhadap keamanan, berkurang kesadaran diri 10. Interaksi social Data obyektif: - Problem berbicara, ketidakmampuan berkomunikasi 11. Pengajaran / pembelajaran Subjektif Data : - Riwayat hipertensi keluarga, stroke - penggunaan kontrasepsi oral 12. Pertimbangan rencana pulang - menentukan regimen medikasi / penanganan terapi - bantuan untuk transportasi, shopping , menyiapkan makanan , perawatan diri dan pekerjaan rumah (DoengesE, Marilyn,2000 hal 292)
6. Diagnosa dan intervensi keperawatan	1. Perubahan perfusi jaringan serebral b.d terputusnya aliran darah : penyakit oklusi, perdarahan, spasme pembuluh darah serebral, edema serebral Kriteria hasil:

	- terpelihara dan meningkatnya tingkat kesadaran, kognisi dan fungsi sensori / motor - menampakan stabilisasi tanda vital dan tidak ada PTIK - Peran pasien menampakan tidak adanya kemunduran / kekambuhan Intervensi : Independen - tentukan factor factor yang berhubungan dengan situasi individu/ penyebab koma / penurunan perfusi serebral dan potensial PTIK - monitor dan catat status neurologist secara teratur - monitor tanda tanda vital - evaluasi pupil 9 ukuran bentuk kesamaan dan reaksi terhadap cahaya 0 - Bantu untuk mengubah pandangan , misalnay pandangan kabur, perubahan lapang pandang / persepsi lapang pandang - Bantu meningkatkan fungsi, termasuk bicara jika pasien mengalami gangguan fungsi - Kepala dielevasikan perlahan lahan pada posisi netral . - Pertahankan tirah baring , sediakan lingkungan yang tenang , atur kunjungan sesuai indikasi Kolaborasi - berikan suplemen oksigen sesuai indikasi - berikan medikasi sesuai indikasi :Antifibrolitik, missal aminocaproic acid (amicar), Antihipertensi, Vasodilator perifer, missal cyclandelate, isoxsuprine, Manitol 2. Ketidakmampuan mobilitas fisik b.d kelemahan neuromuscular, ketidakmampuan dalam persespi kognitif Kriteria hasil; - tidak ada kontraktur, foot drop. - Adanya peningkatan kemampuan fungsi perasaan atau kompensasi dari bagian tubuh - Menampakan kemampuan perilaku / teknik aktivitas sebagaimana permulaanya - Terpeliharanya integritas kulit Intervensi Independen - Rubah posisi tiap dua jam (prone, supine, miring) - Mulai latihan aktif / pasif rentang gerak sendi pada semua ekstremitas - Topang ekstremitas pada posis fungsional , gunakan foot board pada saat selama periode paralysisi flaksid. Pertahankan kepala dalam keadaan netral - Evaluasi penggunaan alat bantu pengatur posisi - Bantu meningkatkan keseimbangan duduk - Bantu memanipulasi untuk mempengaruhi warna kulit edema atau menormalkan sirkulasi - Awasi bagian kulit diatas tonjolan tulang Kolaboratif - konsul kebagian fisioterapi - Bantu dalam meberikan stimulasi elektrik - Gunakan bed air atau bed khusus sesuai indikasi
--	---

	3. Gangguan komunikasi verbal b.d gangguan sirkulasi serebral, gangguan neuromuskuler, kehilangan tonus otot fasial / mulut, kelemahan umum / letih. Kriteria Hasil: - Pasien mampu memahami problem komunikasi - Menentukan metode komunikasi untuk berekspresi - Menggunakan sumber bantuan dengan tepat Intervensi Independen - Bantu menentukan derajat disfungsi - Bedakan antara afasia dengan disartria - Sediakan bel khusus jika diperlukan - Sediakan metode komunikasi alternatif - Antisipasi dan sediakan kebutuhan pasien - Bicara langsung kepada pasien dengan perlahan dan jelas - Bicara dengan nada normal Kolaborasi : - Konsul dengan ahli terapi wicara 4. Perubahan persepsi sensori b.d penerimaan perubahan sensori transmisi, perpaduan (trauma / penurunan neurology), tekanan psikologis (penyempitan lapangan persepsi disebabkan oleh kecemasan) Kriteria hasil : - Dapat mempertahankan level kesadaran dan fungsi persepsi pada level biasanya. - Perubahan pengetahuan dan mampu terlibat - Mendemonstrasikan perilaku untuk kompensasi Intervensi Independen - Kaji patologi kondisi individual - Evaluasi penurunan visual - Lakukan pendekatan dari sisi yang utuh - Sederhanakan lingkungan - Bantu pemahaman sensori - Beri stimulasi terhadap sisa rasa sentuhan - Lindungi pasien dari temperature yang ekstrem - Pertahankan kontak mata saat berhubungan - Validasi persepsi pasien 5. Kurang perawatan diri b.d kerusakan neuro muskuler, penurunan kekuatan dan ketahanan, kehilangan kontrol /koordinasi otot Kriteria hasil: - Melakukan aktivitas perawatan diri dalam tingkat kemampuan sendiri - Mengidentifikasi sumber pribadi /komunitas dalam memberikan bantuan sesuai kebutuhan - Mendemonstrasikan perubahan gaya hidup untuk memenuhi kebutuhan perawatan diri Intervensi:
--	---

	- Kaji kemampuan dantingkat kekurangan (dengan menggunakan skala 1-4) untuk melakukan kebutuhan sehari-hari - Hindari melakukan sesuatu untuk pasien yang dapat dilakukan pasien sendiri, tetapi berikan bantuan sesuai kebutuhan - Kaji kemampuan pasien untuk berkomunikasi tentang kebutuhannya untuk menghindari dan atau kemampuan untuk menggunakan urinal, bedpan. - Identifikasi kebiasaan defekasi sebelumnya dan kembalikan pada kebiasaan pola normal tersebut. Kadar makanan yang berserat, anjurkan untuk minum banyak dan tingkatkan aktivitas. - Berikan umpan balik yang positif untuk setiap usaha yang dilakukan atau keberhasilannya. Kolaborasi; - Berikan supositoria dan pelunak feses - Konsultasikan dengan ahli fisioterapi/okupasi 6. Ketidakefektifan bersihan jalan napas b.d kerusakan batuk, ketidakmampuan mengatasi lender kriteria hasil: - Pasien memperlihatkan kepatenan jalan napas - Ekspansi dada simetris - Bunyi napas bersih saat auskultasi - Tidak terdapat tanda distress pernapasan - GDA dan tanda vital dalam batas normal Intervensi: - Kaji dan pantau pernapasan, reflek batuk dan sekresi - Posisikan tubuh dan kepala untuk menghindari obstruksi jalan napas dan memberikan pengeluaran sekresi yang optimal - Penghisapan sekresi - Auskultasi dada untuk mendengarkan bunyi jalan napas setiap 4 jam - Berikan oksigenasi sesuai advis - Pantau BGA dan Hb sesuai indikasi 4. Gangguan pemenuhan nutrisi b.d reflek menelan turun, hilang rasa ujung lidah Kriteria hasil: - Pasien dapat berpartisipasi dalam intervensi spesifik untuk merangsang nafsu makan - BB stabil - Pasien mengungkapkan pemasukan adekuat Intervensi; - Pantau masukan makanan setiap hari - Ukur BB setiap hari sesuai indikasi - Dorong pasien untuk makan diit tinggi kalori kaya nutrisi sesuai program - Kontrol faktor lingkungan (bau, bising), hindari makanan terlalu manis, berlemak dan pedas. Ciptakan suasana makan yang menyenangkan - Identifikasi pasien yang mengalami mual muntah
--	---

	Kolaborasi: - Pemberian anti emetik dengan jadwal reguler - Vitamin A,D,E dan B6 - Rujuk ahli diit - Pasang /pertahankan slang NGT untuk pemberian makanan enteral (DoengesE, Marilyn,2000 hal 293-305)
--	--



CVA NON HAEMORRHAGIC

1. Pengertian (Definisi)	Stroke atau cedera cerebrovaskuler (CVA) adalah kehilangan fungsi otak yang diakibatkan oleh berhentinya suplai darah ke bagian otak sering ini adalah kulminasi penyakit serebrovaskuler selama beberapa tahun. (Smeltzer C. Suzanne, 2002, hal 2131)
2. Etiologi	Penyebab-penyebabnya antara lain: - Trombosis (bekuan cairan di dalam pembuluh darah otak) - Embolisme cerebral (bekuan darah atau material lain) - Iskemia (Penurunan aliran darah ke area otak) (Smeltzer C. Suzanne, 2002, hal 2131)
3. Tanda dan gejala	Berdasarkan lokasinya di tubuh, gejala-gejala Stroke terbagi menjadi berikut: - Bagian sistem saraf pusat : Kelemahan otot (hemiplegia), kaku, menurunnya fungsi sensorik - Batang otak, dimana terdapat 12 saraf kranial: menurun kemampuan membau, mengecap, mendengar, dan melihat parsial atau keseluruhan, refleks menurun, ekspresi wajah terganggu, pernafasan dan detak jantung terganggu, lidah lemah. - Cerebral cortex: aphasia, apraxia, daya ingat menurun, hemineglect, kebingungan. Jika tanda-tanda dan gejala tersebut hilang dalam waktu 24 jam, dinyatakan sebagai Transient Ischemic Attack (TIA), dimana merupakan serangan kecil atau serangan awal Stroke.
4. Pemeriksaan penunjang	1. CT Scan: Memperlihatkan adanya edema, hematoma, iskemia dan adanya infark 2. Angiografi serebral: membantu menentukan penyebab stroke secara spesifik seperti perdarahan atau obstruksi arteri 3. Pungsi Lumbar: menunjukkan adanya tekanan normal, tekanan meningkat dan cairan yang mengandung darah menunjukkan adanya perdarahan 4. MRI: Menunjukkan daerah yang mengalami infark, hemoragik. 5. EEG: Memperlihatkan daerah lesi yang spesifik 6. Ultrasonografi Dopler: Mengidentifikasi penyakit arteriovenal 7. Sinar X Tengkorak: Menggambarkan perubahan kelenjar lempeng pineal (DoengesE, Marilyn, 2000 hal 292)
5. Pengkajian keperawatan	1. Pengkajian Primer - Airway: Adanya sumbatan/obstruksi jalan napas oleh adanya penumpukan sekret akibat kelemahan reflek batuk - Breathing: Kelemahan menelan/ batuk/ melindungi jalan napas, timbulnya pernapasan yang sulit dan / atau tak teratur, suara nafas terdengar ronchi / aspirasi - Circulation: TD dapat normal atau meningkat, hipotensi terjadi pada tahap lanjut, takikardi, bunyi jantung normal

	pada tahap dini, disritmia, kulit dan membran mukosa pucat, dingin, sianosis pada tahap lanjut 2. Pengkajian Sekunder 1. Aktivitas dan istirahat Data Subyektif: - kesulitan dalam beraktivitas; kelemahan, kehilangan sensasi atau paralysis. - mudah lelah, kesulitan istirahat (nyeri atau kejang otot) Data obyektif: - Perubahan tingkat kesadaran - Perubahan tonus otot (flaksid atau spastic), paraliysis (hemiplegia), kelemahan umum. - gangguan penglihatan 2. Sirkulasi Data Subyektif: - Riwayat penyakit jantung (penyakit katup jantung, disritmia, gagal jantung , endokarditis bacterial), polisitemia. Data obyektif: - Hipertensi arterial - Disritmia, perubahan EKG - Pulsasi: kemungkinan bervariasi - Denyut karotis, femoral dan arteri iliaka atau aorta abdominal 3. Integritas ego Data Subyektif: - Perasaan tidak berdaya, hilang harapan Data obyektif: - Emosi yang labil dan marah yang tidak tepat, kesedihan , kegembiraan - kesulitan berekspresi diri 4. Eliminasi Data Subyektif: - Inkontinensia, anuria distensi abdomen (kandung kemih sangat penuh), tidak adanya suara usus(ileus paralitik) 5. Makan/ minum Data Subyektif: - Nafsu makan hilang - Nausea / vomitus menandakan adanya PTIK - Kehilangan sensasi lidah , pipi , tenggorokan, disfagia - Riwayat DM, Peningkatan lemak dalam darah Data obyektif: - Problem dalam mengunyah (menurunnya reflek palatum dan faring) - Obesitas (factor resiko) 6. Sensori neural Data Subyektif: - Pusing / syncope (sebelum CVA / sementara selama TIA) - Nyeri kepala: pada perdarahan intra serebral atau perdarahan sub arachnoid. - Kelemahan, kesemutan/kebas, sisi yang terkena terlihat seperti lumpuh/mati
--	---

	- Penglihatan berkurang - Sentuhan: kehilangan sensor pada sisi kolateral pada ekstremitas dan pada muka ipsilateral (sisi yang sama) - Gangguan rasa pengecap dan penciuman Data obyektif: - Status mental; koma biasanya menandai stadium perdarahan, gangguan tingkah laku (seperti: letergi, apatis, menyerang) dan gangguan fungsi kognitif - Ekstremitas: kelemahan / paraliysis (kontralateral pada semua jenis stroke, genggaman tangan tidak imbang, berkurangnya reflek tendon dalam (kontralateral) - Wajah: paralisis / parese (ipsilateral) - Afasia (kerusakan atau kehilangan fungsi bahasa, kemungkinan ekspresif/ kesulitan berkata kata, reseptif / kesulitan berkata kata komprehensif, global / kombinasi dari keduanya. - Kehilangan kemampuan mengenal atau melihat, pendengaran, stimuli taktil - Apraksia: kehilangan kemampuan menggunakan motoric - Reaksi dan ukuran pupil: tidak sama dilatasi dan tak bereaksi pada sisi ipsi lateral 7. Nyeri / kenyamanan Data Subyektif: - Sakit kepala yang bervariasi intensitasnya Data obyektif: - Tingkah laku yang tidak stabil, gelisah, ketegangan otot / fasial 8. Respirasi Data Subyektif: - Perokok (factor resiko) - Keamanan Data obyektif: - Motorik/sensorik: masalah dengan penglihatan - Perubahan persepsi terhadap tubuh, kesulitan untuk melihat objek, hilang kewasadaan terhadap bagian tubuh yang sakit - Tidak mampu mengenali objek, warna, kata, dan wajah yang pernah dikenali - Gangguan berespon terhadap panas, dan dingin/gangguan regulasi suhu tubuh - Gangguan dalam memutuskan, perhatian sedikit terhadap keamanan, berkurang kesadaran diri 9. Interaksi social Data obyektif: - Problem berbicara, ketidakmampuan berkomunikasi (Doenges E, Marilyn, 2000 hal 292)
6. Diagnosa dan intervensi keperawatan	1. Perubahan perfusi jaringan serebral b.d terputusnya aliran darah: penyakit oklusi, perdarahan, spasme pembuluh darah serebral, edema serebral - Kriteria hasil; a. Terpelihara dan meningkatnya tingkat kesadaran, kognisi dan fungsi sensori / motor

	b. Menampakan stabilisasi tanda vital dan tidak ada PTIK c. Peran pasien menampakan tidak adanya kemunduran /kekambuhan - Intervensi: - Independen - Tentukan factor factor yang berhubungan dengan situasi individu/ penyebab koma / penurunan perfusi serebral dan potensial PTIK - Monitor dan catat status neurologist secara teratur - Monitor tanda tanda vital - Evaluasi pupil (ukuran bentuk kesamaan dan reaksi terhadap cahaya) - Bantu untuk mengubah pandangan, misalnay pandangan kabur, perubahan lapang pandang /persepsi lapang pandang - Bantu meningkatkan fungsi, termasuk bicara jika pasien mengalami gangguan fungsi - Kepala dielevasikan perlahan lahan pada posisi netral. - Pertahankan tirah baring, sediakan lingkungan yang tenang, atur kunjungan sesuai indikasi - Kolaborasi - berikan suplemen oksigen sesuai indikasi - berikan medikasi sesuai indikasi: Antifibrolitik, misal aminocaproic acid (amicar), Antihipertensi, Vasodilator perifer, missal cyclandelate, isoxsuprine, Manitol 2. Ketidakefektifan bersihan jalan napas b.d kerusakan batuk, ketidakmampuan mengatasi lender - Kriteria hasil: a. Pasien memperlihatkan kepatenan jalan napas b. Ekspansi dada simetris c. Bunyi napas bersih saat auskultasi d. Tidak terdapat tanda distress pernapasan e. GDA dan tanda vital dalam batas normal - Intervensi: - Kaji dan pantau pernapasan, reflek batuk dan sekresi - Posisikan tubuh dan kepala untuk menghindari obstruksi jalan napas dan memberikan pengeluaran sekresi yang optimal - Penghisapan sekresi - Auskultasi dada untuk mendengarkan bunyi jalan napas setiap 4 jam - Berikan oksigenasi sesuai advis - Pantau BGA dan Hb sesuai indikasi 3. Pola nafas tak efektif berhubungan dengan adanya depresan pusat pernapasan - Kriteria hasil: - RR 18-20 x permenit - Ekspansi dada normal - Intervensi: - Kaji frekuensi, irama, kedalaman pernafasan. - Auskultasi bunyi nafas.
--	--

	- Pantau penurunan bunyi nafas. - Pastikan kepatenan O2 binasal - Berikan posisi yang nyaman: semi fowler - Berikan instruksi untuk latihan nafas dalam - Catat kemajuan yang ada pada klien tentang pernafasan
--	---



DHF

1. Pengertian (Definisi)	Dengue Haemorrhagic Fever (DHF) adalah penyakit demam akut yang disertai dengan adanya manifestasi perdarahan, yang bertendensi mengakibatkan renjatan yang dapat menyebabkan kematian. (Arief Mansjoer & Suprohaita; 2000; 419).
2. Etiologi	Penyebab DHF adalah Arbovirus (Arthropodborn Virus) melalui gigitan nyamuk Aedes (Aedes Albopictus dn Aedes Aegepty)
3. Tanda dan gejala	Tanda dan gejala penyakit DHF adalah : - Meningkatnya suhu tubuh - Nyeri pada otot seluruh tubuh - Suara serak - Batuk - Epistaksis - Disuria - Nafsu makan menurun - Muntah - Ptekie - Ekimosis - Perdarahan gusi - Muntah darah - Hematuria masih - Melena Klasifikasi DHF menurut WHO Derajat I - Demam disertai gejala tidak khas, terdapat manifestasi perdarahan (uji tourniquet positif) Derajat II - Derajat I ditambah gejala perdarahan spontan dikulit dan perdarahan lain. Derajat III - Kegagalan sirkulasi darah, nadi cepat dan lemah, tekanan nadi menurun (20 mmhg, kulit dingin, lembab, gelisah, hipotensi) I. Derajat IV - Nadi tak teraba, tekanan darah tak dapat diukur
4. Pemeriksaan penunjang	1. Darah Lengkap = Hemokonsentrasi (Hemaokrit meningkat 20 % atau lebih) Thrombositopeni (100. 000/ mm³ atau kurang) 2. Serologi = Uji HI (hemaaglutinaion Inhibition Test) 3. Rontgen Thorac = Effusi Pleura
7. Penatalaksanaan	Penatalaksanaan penderita dengan DHF adalah sebagai berikut : 1. Tirah baring atau istirahat baring. 2. Diet makan lunak. 3. Minum banyak (2-2,5 liter/24 jam) dapat berupa : susu, teh manis, sirup dan beri penderita sedikit oralit, pemberian

	cairan merupakan hal yang paling penting bagi penderita DHF. 4. Pemberian cairan intravena (biasanya ringer laktat, NaCl Faali) merupakan cairan yang paling sering digunakan. 5. Monitor tanda-tanda vital tiap 3 jam (suhu, nadi, tensi, pernafasan) jika kondisi pasien memburuk, observasi ketat tiap jam. 6. Periksa Hb, Ht dan trombosit setiap hari.g.Pemberian obat antipiretik sebaiknya dari golongan asetaminopen. 7. Monitor tanda-tanda perdarahan lebih lanjut. 8. Pemberian antibiotik bila terdapat kekuatiran infeksi sekunder. 9. Monitor tanda-tanda dan renjatan meliputi keadaan umum, perubahan tanda-tanda vital, hasil pemeriksaan laboratorium yang memburuk. 10. Bila timbul kejang dapat diberikan Diazepam. Pada kasus dengan renjatan pasien dirawat di perawatan intensif dan segera dipasang infus sebagai pengganti cairan yang hilang dan bila tidak tampak perbaikan diberikan plasma atau plasma ekspander atau dekstran sebanyak 20 30 ml/kg BB.Pemberian cairan intravena baik plasma maupun elektrolit dipertahankan 12 48 jam setelah renjatan teratasi. Apabila renjatan telah teratasi nadi sudah teraba jelas, amplitudo nadi cukup besar, tekanan sistolik 20 mmHg, kecepatan plasma biasanya dikurangi menjadi 10 ml/kg BB/jam.Transfusi darah diberikan pada pasien dengan perdarahan gastrointestinal yang hebat. Indikasi pemberian transfusi pada penderita DHF yaitu jika ada perdarahan yang jelas secara klinis dan abdomen yang makin tegang dengan penurunan Hb yang mencolok.Pada DBD tanpa renjatan hanya diberi banyak minum yaitu 1½-2 liter dalam 24 jam. Cara pemberian sedikit demi sedikit dengan melibatkan orang tua. Infus diberikan pada pasien DBD tanpa renjatan apabila : - Pasien terus menerus muntah, tidak dapat diberikan minum sehingga mengancam terjadinya dehidrasi. - Hematokrit yang cenderung mengikat.
8. Pengkajian keperawatan	- Kaji riwayat Keperawatan - Kaji adanya peningkatan suhu tubuh, tanda perdarahan , mual muntah, tidak nafsu makan, nyeri ulu hai, nyeri otot dan tanda – tanda renjatan (denyut nadi cepat dan lemah, hipotensi, kulit dingin dan lembab, terutama pada ekstremitas, sianosis, gelisah, penurunan kesadaran)
9. Diagnosa keperawatan	1. Peningkatan suhu tubuh (hipertermi) berhubungan dengan proses infeksi virus. 2. Kekurangan volume cairan berhubungan dengan peningkatan permeabilitas kapiler, perdarahan, muntah dan demam. 3. Gangguan pemenuhan nutrisi kurang dari kebutuhan berhubungan dengan mual, muntah, anoreksia. 4. Perubahan perfusi jaringan perifer berhubungan dengan perdarahan.

	5. Gangguan rasa nyaman (nyeri) berhubungan dengan kelelahan, malaise sekunder akibat DHF. 6. Kecemasan ringan berhubungan dengan kondisi pasien yang memburuk dan perdarahan yang dialami pasien.
10. Intervensi Keperawatan	1. Peningkatan suhu tubuh (hipertermi) berhubungan dengan proses infeksi virus. a. Tujuan: Anak menunjukkan suhu tubuh dalam batas normal. b. Kriteria hasil : - Suhu tubuh 36-37 °C - Pasien bebas dari demam. c. Rencana tindakan : - Monitor temperatur tubuh Rasional : Perubahan temperatur dapat terjadi pada proses infeksi akut. - Observasi tanda-tanda vital (suhu, tensi, nadi, pernafasan tiap 3 jam atau lebih sering). Rasional : Tanda vital merupakan acuan untuk mengetahui keadaan umum pasien. - Anjurkan pasien untuk minum banyak 1 ½ -2 liter dalam 24 jam. Rasional : Peningkatan suhu tubuh mengakibatkan penguapan tubuh meningkat sehingga perlu diimbangi dengan asupan yang banyak. - Berikan kompres dingin Rasional : Menurunkan panas lewat konduksi. - Berikan antipiretik sesuai program tim medis Rasional : Menurunkan panas pada pusat hipotalamus. 2. Kekurangan volume cairan berhubungan dengan peningkatan permeabilitas kapiler, perdarahan, muntah, dan demam. a. Tujuan : Anak menunjukkan tanda-tanda terpenuhinya kebutuhan cairan. b. Kriteria hasil : - TTV (nadi, tensi) dalam batas normal. - Turgor kulit kembali dalam 1 detik. - Ubun-ubun datar. - Produksi urine 1 cc/ kg/ BB/ jam. - Tidak terjadi syok hipovolemik. c. Rencana tindakan : - Kaji keadaan umum pasien Rasional : Menetapkan data dasar untuk mengetahui dengan cepat penyimpangan dari keadaan normalnya. - Observasi tanda-tanda syok (nadi lemah dan cepat, tensi menurun akral dingin, kesadaran menurun, gelisah) Rasional : Mengetahui tanda syok sedini mungkin sehingga dapat segera dilakukan tindakan. - Monitor tanda-tanda dehidrasi (turgor kulit turun, ubun-ubun cekung produksi urin turun). Rasional : Mengetahui derajat dehidrasi (turgor kulit turun, ubun-ubun cekung produksi urin turun). - Berikan hidrasi peroral secara adekuat sesuai dengan kebutuhan tubuh.

	Rasional : Asupan cairan sangat diperhatikan untuk menambah volume cairan tubuh. - Kolaborasi pemberian cairan intravena RL, glukosa 5% dalam half strenght NaCl 0,9%, Dextran L 40. Rasional : Pemberian cairan ini sangat penting bagi pasien yang mengalami defisit volume cairan dengan keadaan umum yang buruk karena cairan ini langsung masuk ke pembuluh darah. 3. Gangguan pemenuhan nutrisi kurang dari kebutuhan berhubungan dengan mual, muntah dan anoreksia. a. Tujuan : kebutuhan nutrisi pasien terpenuhi. b. Kriteria hasil - Adanya minat/ selera makan. - Porsi makansesuai kebutuhan. - BB dipertahankan sesuai usia. - BB meningkat sesuai usia. c. Rencana tindakan : - Monitor intake makanan - Rasional : Memonitor intake kalori dan insufisiensi kualitas konsumsi makanan. - Memberikan perawatan mulut sebelum dan sesudah makan. - Rasional : Mengurangi rasa tidak nyaman dan meningkatkan selera makan. - Sajikan makanan yang menarik, merangsang selera dan dalam suasana yang menyenangkan. - Rasional : Meningkatkan selera makan sehingga meningkatkan intake makanan. - Berikan makanan dalam porsi kecil tapi sering. - Rasional : Makan dalam porsi besar/ banyak lebih sulit dikonsumsi saat pasien anoreksia. - Timbang BB setiap hari. - Rasional : Memonitor kurangnya BB dan efektifitas intervensi nutrisi yang diberikan. - Konsul ke ahli gizi. - Rasional : Memberikan bantuan untuk menetapkan diet dan merencanakan pertemuan secara individual bila diperlukan. 4. Perubahan perfusi jaringan perifer berhubungan dengan perdarahan. a. Tujuan: Anak menunjukkan tanda-tanda perfusi jaringan perifer yang adekuat. b. Kriteria hasil : - Suhu ekstremitas hangat, tidak lembab, warna merah muda. - Ekstremitas tidak nyeri, tidak ada pembengkakan. - CRT kembali dalam 1 detik. c. Rencana tindakan : - Kaji dan catat tanda-tanda vital (kualitas dan frekuensi nadi, tensi, capillary reffil). Rasional : Tanda vital merupakan acuan untuk
--	--

	mengetahui penurunan perfusi ke jaringan. - Kaji dan catat sirkulasi pada ekstremitas (suhu kelembaban, dan warna). Rasional: Suhu dingin, warna pucat pada ekstremitas menunjukkan sirkulasi darah kurang adekuat. - Nilai kemungkinan kematian jaringan pada ekstremitas seperti dingin, nyeri, pembengkakan, kaki. Rasional : Mengetahui tanda kematian jaringan ekstremitas lebih awal dapat berguna untuk mencegah kematian jaringan. 5. Gangguan rasa nyaman (nyeri) berhubungan dengan kelelahan malaise sekunder akibat DHF. - Tujuan : Rasa nyaman pasien terpenuhi dengan kriteria nyeri berkurang atau hilang. - Rencana tindakan : - Kaji tingkat nyeri yang dialami pasien dengan memberi rentang nyeri (0-10). Rasional : Mengetahui nyeri yang dialami pasien sehingga perawat dapat menentukan cara mengatasinya. - Kaji faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi pasien terhadap nyeri. Rasional : Dengan mengetahui faktor-faktor tersebut maka perawat dapat melakukan intervensi yang sesuai dengan masalah klien. - Berikan posisi yang nyaman dan ciptakan suasana ruangan yang tenang. Rasional : Posisi yang nyaman dan situasi yang tenang dapat membuat perasaan yang nyaman pada pasien. - Berikan suasana gembira bagi pasien, alihkan perhatian pasien dari rasa nyeri dengan mainan, membaca buku cerita. Rasional : Dengan melakukan aktifitas lain pasien dapat sedikit mengalihkan perhatiannya terhadap nyeri. - Kolaborasi pemberian obat-obatan analgesik. Rasional : Obat analgesik dapat menekankan rasa nyeri. 6. Kecemasan ringan berhubungan dengan kondisi pasien yang memburuk dan perdarahan yang dialami pasien. - Tujuan : Kecemasan berkurang dengan kriteria : - Klien tampak lebih tenang. - Klien mau berkomunikasi dengan perawat. - Rencana tindakan : - Kaji rasa cemas yang dialami oleh pasien. Rasional : Menetapkan tingkat kecemasan yang dialami oleh pasien. - Beri kesempatan pada pasien untuk mengungkapkan rasa cemasnya. Rasional : Membantu menenangkan perasaan pasien. - Gunakan komunikasi terapeutik.
--	---

	Rasional : Agar segala sesuatu yang disampaikan pada pasien memberikan hasil yang efektif. - Jaga hubungan saling percaya dari pasien dan keluarga. Rasional : Menjalin hubungan saling percaya antara perawat dengan pasien/ keluarga. - Jawab pertanyaan dari pasien/ keluarga dengan jujur dan benar. Rasional : Jawaban jujur dan benar akan menumbuhkan kepercayaan pasien pada perawat.
--	--



HEPATITIS

1. Pengertian (Definisi)	<i>Hepatitis</i> adalah suatu proses peradangan difus pada jaringan yang dapat disebabkan oleh infeksi virus dan oleh reaksi toksik terhadap obat-obatan serta bahan-bahan kimia. (Sujono Hadi, 1999). <i>Hepatitis virus</i> merupakan infeksi sistemik oleh virus disertai nekrosis dan klinis, biokimia serta seluler yang khas (Smeltzer, 2001)
2. Etiologi	a. Virus type A : sumber penularan dari darah, feces, saliva type B : sumber penularan dari darah, saliva, semen, sekresi vagina type C : sumber penularan terutama dari darah type D : sumber penularan dari darah type E : sumber penularan dari darah, feces, saliva b. Alkohol Menyebabkan alkohol hepatitis dan selanjutnya menjadi alkohol sirosis. c. Obat-obatan Menyebabkan toksik untuk hati, sehingga sering disebut hepatitis toksik dan hepatitis akut.
3. Tanda dan gejala	a. Masa tunas Virus A : 15-45 hari (rata-rata 25 hari) Virus B : 40-180 hari (rata-rata 75 hari) Virus non A dan non B : 15-150 hari (rata-rata 50 hari) b. <i>Fase Pre Ikterik</i> Keluhan umumnya tidak khas. Keluhan yang disebabkan infeksi virus berlangsung sekitar 2-7 hari. Nafsu makan menurun (pertama kali timbul), nausea, vomitus, perut kanan atas (ulu hati) dirasakan sakit. Seluruh badan pegal-pegal terutama di pinggang, bahu dan malaise, lekas capek terutama sore hari, suhu badan meningkat sekitar 39°C berlangsung selama 2-5 hari, pusing, nyeri persendian. Keluhan gatal-gatal mencolok pada hepatitis virus B. c. <i>Fase Ikterik</i> Urine berwarna seperti teh pekat, tinja berwarna pucat, penurunan suhu badan disertai dengan bradikardi. Ikterus pada kulit dan sklera yang terus meningkat pada minggu I, kemudian menetap dan baru berkurang setelah 10-14 hari. Kadang-kadang disertai gatal-gatal pada seluruh badan, rasa lesu dan lekas capai dirasakan selama 1-2 minggu. D. <i>Fase penyembuhan</i> Dimulai saat menghilangnya tanda-tanda ikterus, rasa mual, rasa sakit di ulu hati, disusul bertambahnya nafsu makan, rata-rata 14-15 hari setelah timbulnya masa ikterik. Warna urine tampak normal, penderita mulai merasa segar kembali, namun lemas.

E. Pemeriksaan penunjang	1. Laboratorium a. Pemeriksaan pigmen - urobilirubin direk - bilirubin serum total - bilirubin urine - urobilinogen urine - urobilinogen feses b. Pemeriksaan protein - protein total serum - albumin serum - globulin serum - HbsAG c. Waktu protombin - respon waktu protombin terhadap vitamin K d. Pemeriksaan serum transferase dan transaminase - AST atau SGOT - ALT atau SGPT - LDH - Amonia serum 2. Radiologi a. foto rontgen abdomen b. pemindahan hati dengan preparat technetium, emas, atau rose bengal yang berlabel radioaktif c. kolesistogram dan kalangiogram d. arteriografi pembuluh darah seliaka 3. Pemeriksaan tambahan a. laparoskopi b. biopsi hati
--	---

F. Pengkajian keperawatan	Data dasar tergantung pada penyebab dan beratnya kerusakan/gangguan hati 1. Aktivitas ⇒ Kelemahan ⇒ Kelelahan ⇒ Malaise 2. Sirkulasi ⇒ Bradikardi (hiperbilirubin berat) ⇒ Ikterik pada sklera kulit, membran mukosa 3. Eliminasi ⇒ Urine gelap ⇒ Diare feses warna tanah liat 4. Makanan dan Cairan ⇒ Anoreksia ⇒ Berat badan menurun ⇒ Mual dan muntah ⇒ Peningkatan oedema ⇒ Asites 5. Neurosensori ⇒ Peka terhadap rangsang ⇒ Cenderung tidur ⇒ Letargi ⇒ Asteriksis 6. Nyeri / Kenyamanan ⇒ Kram abdomen ⇒ Nyeri tekan pada kuadran kanan ⇒ Mialgia ⇒ Atrialgia ⇒ Sakit kepala ⇒ Gatal (pruritus) 7. Keamanan ⇒ Demam ⇒ Urtikaria ⇒ Lesi makulopopuler ⇒ Eritema ⇒ Splenomegali ⇒ Pembesaran nodus servikal posterior 8. Seksualitas Pola hidup / perilaku meningkat resiko terpajan
----------------------------------	--

G. Diagnosa dan intervensi keperawatan	1. <i>Perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh</i> berhubungan dengan, perasaan tidak nyaman di kuadran kanan atas, gangguan absorpsi dan metabolisme pencernaan makanan, kegagalan masukan untuk memenuhi kebutuhan metabolik karena anoreksia, mual dan muntah. <i>Hasil yang diharapkan</i> : Menunjukkan peningkatan berat badan mencapai tujuan dengan nilai laboratorium normal dan bebas dari tanda-tanda mal nutrisi. a. Ajarkan dan bantu klien untuk istirahat sebelum makan R/ kelelahan berlanjut menurunkan keinginan untuk makan b. Awasi pemasukan diet/jumlah kalori, tawarkan makan sedikit tapi sering dan tawarkan pagi paling sering R/ adanya pembesaran hepar dapat menekan saluran gastro intestinal dan menurunkan kapasitasnya. c. Pertahankan hygiene mulut yang baik sebelum makan dan sesudah makan R/ akumulasi partikel makanan di mulut dapat menambah baru dan rasa tak sedap yang menurunkan nafsu makan. d. Anjurkan makan pada posisi duduk tegak R/ menurunkan rasa penuh pada abdomen dan dapat meningkatkan pemasukan e. Berikan diet tinggi kalori, rendah lemak R/ glukosa dalam karbohidrat cukup efektif untuk pemenuhan energi, sedangkan lemak sulit untuk diserap/dimetabolisme sehingga akan membebani hepar. 2. <i>Gangguan rasa nyaman (nyeri)</i> berhubungan dengan pembengkakan hepar yang mengalami inflamasi hati dan bendungan vena porta. <i>Hasil yang diharapkan</i> : Menunjukkan tanda-tanda nyeri fisik dan perilaku dalam nyeri (tidak meringis kesakitan, menangis intensitas dan lokasinya) a. Kolaborasi dengan individu untuk menentukan metode yang dapat digunakan untuk intensitas nyeri R/ nyeri yang berhubungan dengan hepatitis sangat tidak nyaman, oleh karena terdapat peregangan secara kapsula hati, melalui pendekatan kepada individu yang mengalami perubahan kenyamanan nyeri diharapkan lebih efektif mengurangi nyeri. b. Tunjukkan pada klien penerimaan tentang respon klien terhadap nyeri - Akui adanya nyeri - Dengarkan dengan penuh perhatian ungkapan klien tentang nyerinya R/ klienlah yang harus mencoba meyakinkan pemberi pelayanan kesehatan bahwa ia mengalami nyeri c. Berikan informasi akurat dan - Jelaskan penyebab nyeri - Tunjukkan berapa lama nyeri akan berakhir, bila diketahui R/ klien yang disiapkan untuk mengalami nyeri melalui penjelasan nyeri yang sesungguhnya akan dirasakan
--	---

	(cenderung lebih tenang dibanding klien yang penjelasan kurang/tidak terdapat penjelasan) d. Bahas dengan dokter penggunaan analgetik yang tak mengandung efek hepatotoksi R/ kemungkinan nyeri sudah tak bisa dibatasi dengan teknik untuk mengurangi nyeri. 3. <i>Hypertermi</i> berhubungan dengan invasi agent dalam sirkulasi darah sekunder terhadap inflamasi hepar. <i>Hasil yang diharapkan :</i> Tidak terjadi peningkatan suhu a. Monitor tanda vital : suhu badan R/ sebagai indikator untuk mengetahui status hypertermi b. Ajarkan klien pentingnya mempertahankan cairan yang adekuat (sedikitnya 2000 l/hari) untuk mencegah dehidrasi, misalnya sari buah 2,5-3 liter/hari. R/ dalam kondisi demam terjadi peningkatan evaporasi yang memicu timbulnya dehidrasi. c. Berikan kompres hangat pada lipatan ketiak dan femur R/ menghambat pusat simpatis di hipotalamus sehingga terjadi vasodilatasi kulit dengan merangsang kelenjar keringat untuk mengurangi panas tubuh melalui penguapan d. Anjurkan klien untuk memakai pakaian yang menyerap keringat R/ kondisi kulit yang mengalami lembab memicu timbulnya pertumbuhan jamur. Juga akan mengurangi kenyamanan klien, mencegah timbulnya ruam kulit. 4. <i>Keletihan</i> berhubungan dengan proses inflamasi kronis sekunder terhadap hepatitis a. Jelaskan sebab-sebab keletihan individu R/ dengan penjelasan sebab-sebab keletihan maka keadaan klien cenderung lebih tenang b. Sarankan klien untuk tirah baring R/ tirah baring akan meminimalkan energi yang dikeluarkan sehingga metabolisme dapat digunakan untuk penyembuhan penyakit. c. Bantu individu untuk mengidentifikasi kekuatan-kekuatan, kemampuan-kemampuan dan minat-minat R/ memungkinkan klien dapat memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang sangat penting dan meminimalkan pengeluaran energi untuk kegiatan yang kurang penting d. Analisa bersama-sama tingkat keletihan selama 24 jam meliputi waktu puncak energi, waktu kelelahan, aktivitas yang berhubungan dengan keletihan R/ keletihan dapat segera diminimalkan dengan mengurangi kegiatan yang dapat menimbulkan keletihan e. Bantu untuk belajar tentang keterampilan coping yang efektif (bersikap asertif, teknik relaksasi) R/ untuk mengurangi keletihan baik fisik maupun psikologis.
--	---

	5. <i>Resiko tinggi kerusakan integritas kulit dan jaringan</i> berhubungan dengan pruritus sekunder terhadap akumulasi pigmen bilirubin dalam garam empedu <i>Hasil yang diharapkan :</i> Jaringan kulit utuh, penurunan pruritus. a. Pertahankan kebersihan tanpa menyebabkan kulit kering - Sering mandi dengan menggunakan air dingin dan sabun ringan (kadtril, lanolin) - Keringkan kulit, jaringan digosok R/ kekeringan meningkatkan sensitifitas kulit dengan merangsang ujung syaraf b. Cegah penghangatan yang berlebihan dengan pertahankan suhu ruangan dingin dan kelembaban rendah, hindari pakaian terlalu tebal R/ penghangatan yang berlebih menambah pruritus dengan meningkatkan sensitivitas melalui vasodilatasi c. Anjurkan tidak menggaruk, instruksikan klien untuk memberikan tekanan kuat pada area pruritus untuk tujuan menggaruk R/ penggantian merangsang pelepasan histamin, menghasilkan lebih banyak pruritus d. Pertahankan kelembaban ruangan pada 30%-40% dan dingin R/ pendinginan akan menurunkan vasodilatasi dan kelembaban kekeringan 6. <i>Pola nafas tidak efektif</i> berhubungan dengan pengumpulan cairan intraabdomen, asites penurunan ekspansi paru dan akumulasi sekret. <i>Hasil yang diharapkan :</i> Pola nafas adekuat <i>Intervensi :</i> a. Awasi frekwensi , kedalaman dan upaya pernafasan R/ pernafasan dangkal/cepat kemungkinan terdapat hipoksia atau akumulasi cairan dalam abdomen b. Auskultasi bunyi nafas tambahan R/ kemungkinan menunjukkan adanya akumulasi cairan c. Berikan posisi semi fowler R/ memudahkan pernafasan dengan menurunkan tekanan pada diafragma dan meminimalkan ukuran sekret d. Berikan latihan nafas dalam dan batuk efektif R/ membantu ekspansi paru dalam memobilisasi lemak e. Berikan oksigen sesuai kebutuhan R/ mungkin perlu untuk mencegah hipoksia 7. <i>Risiko tinggi terhadap transmisi infeksi</i> berhubungan dengan sifat menular dari agent virus <i>Hasil yang diharapkan :</i> Tidak menunjukkan tanda-tanda infeksi. a. Gunakan kewaspadaan umum terhadap substansi tubuh yang tepat untuk menangani semua cairan tubuh - Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan semua klien atau spesimen
--	--

	- Gunakan sarung tangan untuk kontak dengan darah dan cairan tubuh - Tempatkan spuit yang telah digunakan dengan segera pada wadah yang tepat, jangan menutup kembali atau memanipulasi jarum dengan cara apapun R/ pencegahan tersebut dapat memutuskan metode transmisi virus hepatitis b. Gunakan teknik pembuangan sampah infeksius, linen dan cairan tubuh dengan tepat untuk membersihkan peralatan-peralatan dan permukaan yang terkontaminasi R/ teknik ini membantu melindungi orang lain dari kontak dengan materi infeksius dan mencegah transmisi penyakit c. Jelaskan pentingnya mencuci tangan dengan sering pada klien, keluarga dan pengunjung lain dan petugas pelayanan kesehatan. R/ mencuci tangan menghilangkan organisme yang merusak rantai transmisi infeksi d. Rujuk ke petugas pengontrol infeksi untuk evaluasi departemen kesehatan yang tepat R/ rujukan tersebut perlu untuk mengidentifikasi sumber pemajanan dan kemungkinan orang lain terinfeksi
--	--



HIPERTENSI

1. Pengertian (Definisi)	Hipertensi dapat didefinisikan sebagai tekanan darah persisten dimana tekanan sistoliknya diatas 140 mmHg dan tekanan diastoliknya diatas 90 mmHg.(Smith Tom, 1995) Menurut WHO, penyakit hipertensi merupakan peningkatan tekanan sistolik lebih besar atau sama dengan 160 mmHg dan atau tekanan diastolic sama atau lebih besar 95 mmHg (Kodim Nasrin, 2003). Hipertensi dikategorikan ringan apabila tekanan diastoliknya antara 95 – 104 mmHg, hipertensi sedang jika tekanan diastoliknya antara 105 dan 114 mmHg, dan hipertensi berat bila tekanan diastoliknya 115 mmHg atau lebih. Pembagian ini berdasarkan peningkatan tekanan diastolic karena dianggap lebih serius dari peningkatan sistolik (Smith Tom, 1995).
2. Etiologi	Hipertensi berdasarkan penyebabnya dapat dibedakan menjadi 2 golongan besar yaitu : (Lany Gunawan, 2001) 1. Hipertensi essensial (hipertensi primer) yaitu hipertensi yang tidak diketahui penyebabnya 2. Hipertensi sekunder yaitu hipertensi yang di sebabkan oleh penyakit lain Hiperrtensi primer terdapat pada lebih dari 90% penderita hipertensi, sedangkan 10% sisanya disebabkan oleh hipertensi sekunder. Meskipun hipertensi primer belum diketahui dengan pasti penyebabnya, data-data penelitian telah menemukan beberapa factor yang sering menyebabkan terjadinya hipertensi. Factor tersebut adalah sebagai berikut : b. Faktor keturunan Dari data statistik terbukti bahwa seseorang akan memiliki kemungkinan lebih besar untuk mendapatkan hipertensi jika orang tuanya adalah penderita hipertensi c. Ciri perseorangan Cirri perseorangan yang mempengaruhi timbulnya hipertensi adalah umur (jika umur bertambah maka TD meningkat), jenis kelamin (laki-laki lebih tinggi dari perempuan) dan ras (ras kulit hitam lebih banyak dari kulit putih) d. Kebiasaan hidup Kebiasaan hidup yang sering menyebabkan timbulnya hipertensi adalah konsumsi garam yang tinggi (melebihi dari 30 gr), kegemukan atau makan berlebihan, stress dan pengaruh lain misalnya merokok, minum alcohol, minum obat-obatan (ephedrine, prednison, epineprin)
3. Tanda dan gejala	Tanda dan gejala pada hipertensi dibedakan menjadi : (Edward K Chung, 1995) 1. Tidak ada gejala Tidak ada gejala yang spesifik yang dapat dihubungkan dengan peningkatan tekanan darah, selain penentuan tekanan arteri oleh dokter yang memeriksa. Hal ini berarti hipertensi arterial tidak akan

	pernah terdiagnosa jika tekanan arteri tidak terukur. 2. Gejala yang lazim Sering dikatakan bahwa gejala terlazim yang menyertai hipertensi meliputi nyeri kepala dan kelelahan. Dalam kenyataannya ini merupakan gejala terlazim yang mengenai kebanyakan pasien yang mencari pertolongan medis.
4. Pemeriksaan penunjang	- Riwayat dan pemeriksaan fisik secara menyeluruh - Pemeriksaan retina - Pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui kerusakan organ seperti ginjal dan jantung - EKG untuk mengetahui hipertropi ventrikel kiri - Urinalisa untuk mengetahui protein dalam urin, darah, glukosa - Pemeriksaan : renogram, pielogram intravena arteriogram renal, pemeriksaan fungsi ginjal terpisah dan penentuan kadar urin. - Foto dada dan CT scan
5. Pengkajian keperawatan	- Aktivitas / istirahat Gejala : kelemahan, letih, napas pendek, gaya hidup monoton Tanda : frekuensi jantung meningkat, perubahan irama jantung, takipnea - Sirkulasi Gejala : Riwayat hipertensi, aterosklerosis, penyakit jantung koroner, penyakit serebrovaskuler Tanda : Kenaikan TD, hipotensi postural, takhikardi, perubahan warna kulit, suhu dingin - Integritas Ego Gejala : Riwayat perubahan kepribadian, ansietas, depresi, euphoria, factor stress multiple Tanda : Letupan suasana hati, gelisah, penyempitan kontinue perhatian, tangisan yang meledak, otot muka tegang, pernapasan menghela, peningkatan pola bicara - Eliminasi Gejala : gangguan ginjal saat ini atau yang lalu - Makanan / Cairan Gejala : makanan yang disukai yang dapat mencakup makanan tinggi garam, lemak dan kolesterol Tanda : BB normal atau obesitas, adanya edema - Neurosensori Gejala : keluhan pusing/pening, sakit kepala, berdenyut sakit kepala, berdenyut, gangguan penglihatan, episode epistaksis Tanda : , perubahan orientasi, penurunan kekuatan genggaman, perubahan retinal optic - Nyeri/ketidaknyamanan Gejala : Angina, nyeri hilang timbul pada tungkai, sakit kepala oksipital berat, nyeri abdomen - Pernapasan Gejala : dispnea yang berkaitan dengan aktivitas, takipnea, ortopnea, dispnea nocturnal proksimal, batuk dengan atau tanpa sputum, riwayat merokok Tanda : distress respirasi/ penggunaan otot aksesoris pernapasan, bunyi napas tambahan, sianosis

	i. Keamanan Gejala : Gangguan koordinasi, cara jalan Tanda : episode parestesia unilateral transien, hipotensi postural j. Pembelajaran/Penyuluhan Gejala : factor resiko keluarga ; hipertensi, aterosklerosis, penyakit jantung, DM , penyakit ginjal k. Faktor resiko etnik, penggunaan pil KB atau hormon
6. Diagnosa dan intervensi keperawatan	a. Resiko tinggi terhadap penurunan curah jantung berhubungan dengan peningkatan afterload, vasokonstriksi, iskemia miokard, hipertropi ventricular Tujuan : Afterload tidak meningkat, tidak terjadi vasokonstriksi, tidak terjadi iskemia miokard Intervensi keperawatan : - Pantau TD, ukur pada kedua tangan, gunakan manset dan tehnik yang tepat - Catat keberadaan, kualitas denyutan sentral dan perifer - Auskultasi tonus jantung dan bunyi napas - Amati warna kulit, kelembaban, suhu dan masa pengisian kapiler - Catat edema umum - Berikan lingkungan tenang, nyaman, kurangi aktivitas. - Pertahankan pembatasan aktivitas seperti istirahat ditemapt tidur/kursi - Bantu melakukan aktivitas perawatan diri sesuai kebutuhan - Lakukan tindakan yang nyaman spt pijatan punggung dan leher - Anjurkan tehnik relaksasi, panduan imajinasi, aktivitas pengalihan - Pantau respon terhadap obat untuk mengontrol tekanan darah - Berikan pembatasan cairan dan diit natrium sesuai indikasi - Kolaborasi untuk pemberian obat-obatan sesuai indikasi b. Nyeri (sakit kepala) berhubungan dengan peningkatan tekanan vaskuler serebral. Tujuan : Tekanan vaskuler serebral tidak meningkat Intervensi keperawatan : - Pertahankan tirah baring, lingkungan yang tenang, sedikit penerangan - Minimalkan gangguan lingkungan dan rangsangan - Batasi aktivitas - Hindari merokok atau menggunakan penggunaan nikotin - Beri obat analgesia dan sedasi sesuai pesanan - Beri tindakan yang menyenangkan sesuai indikasi seperti kompres es, posisi nyaman, tehnik relaksasi, bimbingan imajinasi, hindari konstipasi c. Potensial perubahan perfusi jaringan: serebral, ginjal, jantung berhubungan dengan gangguan sirkulasi Tujuan : sirkulasi tubuh tidak terganggu Intervensi : - Pertahankan tirah baring; tinggikan kepala tempat tidur - Kaji tekanan darah saat masuk pada kedua lengan; tidur, duduk dengan pemantau tekanan arteri jika tersedia - Pertahankan cairan dan obat-obatan sesuai pesanan - Amati adanya hipotensi mendadak - Ukur masukan dan pengeluaran

	- Pantau elektrolit, BUN, kreatinin sesuai pesanan - Ambulasi sesuai kemampuan; hindari kelelahan d. Kurangnya pengetahuan berhubungan dengan kurangnya informasi tentang proses penyakit dan perawatan diri Tujuan ;Klien terpenuhi dalam informasi tentang hipertensi - Jelaskan sifat penyakit dan tujuan dari pengobatan dan prosedur - Jelaskan pentingnya lingkungan yang tenang, tidak penuh dengan stress - Diskusikan tentang obat-obatan : nama, dosis, waktu pemberian, tujuan dan efek samping atau efek toksik - Jelaskan perlunya menghindari pemakaian obat bebas tanpa pemeriksaan dokter - Diskusikan gejala kambuhan atau kemajuan penyulit untuk dilaporkan dokter : sakit kepala, pusing, pingsan, mual dan muntah. - Diskusikan pentingnya mempertahankan berat badan stabil - Diskusikan pentingnya menghindari kelelahan dan mengangkat berat - Diskusikan perlunya diet rendah kalori, rendah natrium sesuai pesanan - Jelaskan pentingnya mempertahankan pemasukan cairan yang tepat, jumlah yang diperbolehkan, pembatasan seperti kopi yang mengandung kafein, teh serta alkohol - Jelaskan perlunya menghindari konstipasi dan penahanan
--	--



INFARK MIOCARD AKUT

1. Pengertian (Definisi)	Infark miokard adalah kematian/nekrosis jaringan miokard akibat penurunan secara tiba-tiba aliran darah arteri koronaria ke jantung atau terjadinya peningkatan kebutuhan oksigen secara tiba-tiba tanpa perfusi arteri koronaria yang cukup.
2. Etiologi	Infark miokard dapat disebabkan oleh : ↳ penyempitan kritis arteri koroner akibat aterosklerosis atau oklusi arteri komplis akibat embolus atau trombus. ↳ Penurunan aliran darah koroner dapat juga disebabkan oleh syok dan hemoragi. ↳ Ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen miokard.
3. Tanda dan gejala	Tanda dan gejala infark miokard (TRIAGE) adalah : 1. Klinis a. Nyeri dada yang terjadi secara mendadak dan terus-menerus tidak mereda, biasanya diatas region sternal bawah dan abdomen bagian atas, ini merupakan gejala utama. b. Keparahan nyeri dapat meningkat secara menetap sampai nyeri tidak tertahankan lagi. c. Nyeri tersebut sangat sakit, seperti tertusuk-tusuk yang dapat menjalar ke bahu dan terus ke bawah menuju lengan (biasanya lengan kiri). d. Nyeri mulai secara spontan (tidak terjadi setelah kegiatan atau gangguan emosional), menetap selama beberapa jam atau hari, dan tidak hilang dengan bantuan istirahat atau nitrogliserin (NTG). e. Nyeri dapat menjalar ke arah rahang dan leher. f. Nyeri sering disertai dengan sesak nafas, pucat, dingin, diaforesis berat, pening atau kepala terasa melayang dan mual muntah. g. Pasien dengan diabetes melitus tidak akan mengalami nyeri yang hebat karena neuropati yang menyertai diabetes dapat mengganggu neuroreseptor (menumpulkan pengalaman nyeri)
4. Pemeriksaan penunjang	1. Laboratorium - Pemeriksaan Enzim jantung - CPK-MB/CPK - Isoenzim yang ditemukan pada otot jantung meningkat antara 4-6 jam, memuncak dalam 12-24 jam, kembali normal dalam 36-48 jam. - LDH/HBDH - Meningkat dalam 12-24 jam dan memakan waktu lama untuk kembali normal

	- AST/SGOT - Meningkat (kurang nyata/khusus) terjadi dalam 6-12 jam, memuncak dalam 24 jam, kembali normal dalam 3 atau 4 hari 2. EKG Perubahan EKG yang terjadi pada fase awal adanya gelombang T tinggi dan simetris. Setelah ini terdapat elevasi segmen ST Perubahan yang terjadi kemudian ialah adanya gelombang Q/QS yang menandakan adanya nekrosis.
--	---

H. Penatalaksanaan	Tujuan penatalaksanaan medis adalah untuk meminimalkan kerusakan miokard dengan: menghilangkan nyeri, memberikan istirahat dan mencegah timbulnya komplikasi seperti disritmia letal dan syok kardiogenik. 1. Pemberian oksigen dilakukan saat awitan nyeri dada. 2. Analgesik (morfin sulfat). Farmakoterapi : ⇒ Vasodilator untuk meningkatkan suplai oksigen (NTG). ⇒ Antikoagulan (Heparin). ⇒ Trombolitik (streptokinase, aktivator plasminogen jenis jaringan <t-pA> , anistreplase) hanya akan efektif bila diberikan dalam 6 jam awitan nyeri dada, selama terjadi nekrosis jaringan transmural.
---------------------------	---

I. Pengkajian keperawatan	Tetapkan penatalaksanaan dasar untuk mendapatkan informasi tentang status terakhir pasien sehingga semua penyimpangan yang terjadi dapat segera diketahui. 1. Riwayat atau adanya faktor-faktor resiko : ❑ Penyakit pembuluh darah arteri. ❑ Serangan jantung sebelumnya. ❑ Riwayat keluarga atas penyakit jantung/serangan jantung positif. ❑ Kolesterol serum tinggi (diatas 200 mg/L). ❑ Perokok ❑ Diet tinggi garam dan tinggi lemak. ❑ Kegemukan.(BB idealTB –100 ± 10 %) ❑ Wanita pasca menopause karena terapi estrogen. 2. Pemeriksaan fisik berdasarkan pengkajian kardiovaskuler dapat menunjukkan : ➢ Nyeri dada berkurang dengan istirahat atau pemberian nitrat (temuan yang paling penting) sering juga disertai: • Perasaan ancaman pingsan dan atau kematian • Diaforesis. • Mual dan muntah kadang-kadang. • Dispneu. • Sindrom syok dalam berbagai tingkatan (pucat, dingin, kulit lembab atau basah, turunnya tekanan darah, denyut nadi yang cepat, berkurangnya nadi perifer dan bunyi jantung). • Demam (dalam 24 – 48 jam). 3. Kaji nyeri dada sehubungan dengan: ❑ Faktor perangsang. ❑ Kualitas. ❑ Lokasi. ❑ Beratnya. 4. Pemeriksaan Diagnostik ❑ EKG, menyatakan perpindahan segmen ST, gelombang Q, dan perubahan gelombang T. ❑ Berdasarkan hasil sinar X dada terdapat pembesaran jantung dan kongestif paru. ❑ Enzim jantung (Gawlinski, 1989) • Kreatinin kinase (CK) – isoenzim MB mulai naik dalam 6 jam, memuncak dalam 18 – 24 jam dan kembali normal antara 3 – 4 hari, tanpa terjadinya neurosis baru. Enzim CK – MB ssering dijadikan sebagai indikator Infark Miokard. • Laktat dehidrogenase (LDH) mulai meningkat dalam 6 – 12 jam, memuncak dalam 3 – 4 hari dan normal 6 –12 hari. • Aspartat aminotransferase serum (AST) mulai meningkat dalam 8 – 12 jam dan bertambah pekat dalam 1 – 2 hari. Enzim ini muncul dengan kerusakan yang hebat dari otot tubuh. ❑ Test tambahan termasuk pemeriksaan elektrolit serum, lipid serum, urinalisis, analisa gas darah (AGD).
---	--

J. Diagnosa intervensi keperawatan dan	3. Gangguan perfusi jaringan Dapat dihubungkan dengan: Iskemik, kerusakan otot jantung, penyempitan / penyumbatan pembuluh darah arteri koronaria Tujuan: Gangguan perfusi jaringan berkurang / tidak meluas selama dilakukan tindakan perawatan di RS. Kriteria: Daerah perifer hangat, tak sianosis, gambaran EKG tak menunjukkan perluasan infark RR 16-24 x/ menit tak terdapat clubbing finger, kapiler refill 3-5 detik, nadi 60-100x / menit, TD 120/80 mmHg Rencana Tindakan: ↳ Monitor Frekuensi dan irama jantung ↳ Observasi perubahan status mental ↳ Observasi warna dan suhu kulit / membran mukosa ↳ Ukur haluaran urin dan catat berat jenisnya ↳ Kolaborasi: Berikan cairan IV I sesuai indikasi ↳ Pantau Pemeriksaan diagnostik / dan laboratorium mis EKG, elektrolit, GDA (Pa O₂, Pa CO₂ dan saturasi O₂). Dan Pemberian oksigen 4. Nyeri Dapat dihubungkan dengan: Iskemia jaringan sekunder terhadap sumbatan arteri coroner. Tujuan: Nyeri berkurang setelah dilakukan tindakan perawatan selama Kriteria: Nyeri dada berkurang misalnya dari skala 3 ke 2, atau dari 2 ke 1, ekspresi wajah rileks / tenang, tak tegang, tidak gelisah nadi 60-100 x / menit, Td 120/ 80 mmHg Rencana tindakan: ↳ Observasi karakteristik, lokasi, waktu, dan perjalanan rasa nyeri dada tersebut. ↳ Anjurkan pada klien menghentikan aktifitas selama ada serangan dan istirahat. ↳ Bantu klien melakukan tehnik relaksasi, mis nafas dalam, perilaku distraksi, visualisasi, atau bimbingan imajinasi. ↳ Pertahankan Oksigenasi dengan bikanul contohnya (2-4 L/ menit) ↳ Monitor tanda-tanda vital (Nadi & tekanan darah) tiap dua jam. ↳ Kolaborasi dengan tim kesehatan dalam pemberian analgetik. 5. Kemungkinan terhadap kelebihan volume cairan ekstrasvaskuler Faktor resiko meliputi: Penurunan perfusi ginjal, peningkatan natrium/ retensi air, peningkatan tekanan hidrostatik atau penurunan protein plasma (menyerap cairan dalam area interstisial/ jaringan) Tujuan: Keseimbangan volume cairan dapat dipertahankan selama dilakukan tindakan keperawatan selama di RS Kriteria: Mempertahankan keseimbangan cairan seperti dibuktikan oleh
--	--

	tekanan darah dalam batas normal, tak ada distensi vena perifer/ vena dan edema dependen, paru bersih dan berat badan ideal (BB idealTB $-100 \pm 10 \%$) Perencanaan tindakan: ↳ Ukur masukan / haluaran, catat penurunan, pengeluaran, sifat konsentrasi, hitung keseimbangan cairan ↳ Observasi adanya oedema dependen ↳ Timbang BB tiap hari ↳ Pertahankan masukan total cairan 2000 ml/24 jam dalam toleransi kardiovaskuler ↳ Kolaborasi: pemberian diet rendah natrium, berikan diuetik. 6. Kerusakan pertukaran gas Dapat dihubungkan oleh: Gangguan aliran darah ke alveoli atau kegagalan utama paru, perubahan membran alveolar- kapiler (atelektasis, kolaps jalan nafas/ alveolar edema paru/efusi, sekresi berlebihan / perdarahan aktif Tujuan: Oksigenasi dengan GDA dalam rentang normal ($pa O_2 < 80$ mmHg, $pa Co_2 > 45$ mmHg dan Saturasi < 80 mmHg) setelah dilakukan tindakan keperawatan selama di RS. Kriteria hasil: Tidak sesak nafas, tidak gelisah, GDA dala batas Normal ($pa O_2 < 80$ mmHg, $pa Co_2 > 45$ mmHg dan Saturasi < 80 mmHg) Tindakan: ↳ Catat frekuensi & kedalaman pernafasan, penggunaan otot Bantu pernafasan ↳ Auskultasi paru untuk mengetahui penurunan / tidak adanya bunyi nafas dan adanya bunyi tambahan missal krakles, ronki dll. ↳ Lakukan tindakan untuk memperbaiki / mempertahankan jalan nafas misalnya, batuk, penghisapan lendir dll. ↳ Tinggikan kepala / tempat tidur sesuai kebutuhan / toleransi pasien ↳ Kaji toleransi aktifitas misalnya keluhan kelemahan/ kelelahan selama kerja atau tanda vital berubah. 7. Intoleransi aktifitas dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari Dapat dihubungkan dengan: ketidakseimbangan antar suplai oksigen miocard dan kebutuhan, adanya iskemik/ nekrotik jaringan miocard. Tujuan : Terjadi peningkatan toleransi pada klien setelah dilaksanakan tindakan keperawatan selama di RS Kriteria : frekuensi jantung 60-100 x/ menit dan TD 120-80 mmHg Rencana tindakan :: ↳ Catat frekuensi jantung, irama, dan perubahan TD selama dan sesudah aktifitas ↳ Tingkatkan istirahat (di tempat tidur) ↳ Batasi aktifitas pada dasar nyeri dan berikan aktifitas sensori yang tidak berat.
--	--

	✎ Jelaskan pola peningkatan bertahap dari tingkat aktifitas, contoh bangun dari kursi bila tidak ada nyeri, ambulasi dan istirahat selama 1 jam setelah makan. ✎ Kaji ulang tanda gangguan yang menunjukkan tidak toleran terhadap aktifitas atau memerlukan pelaporan pada dokter. 8. Kurang pengetahuan mengenai kondisi, kebutuhan pengobatan Dapat dihubungkan dengan : Kurang informasi tentang fungsi jantung / implikasi penyakit jantung dan status kesehatan yang akan datang, kebutuhan perubahan pola hidup. Tujuan : Pengetahuan klien tentang kondisi penyakitnya menguat setelah diberi pendidikan kesehatan selama di RS Kriteria : ✎ Menyatakan pemahaman tentang penyakit jantung, rencana pengobatan, tujuan pengobatan & efek samping / reaksi merugikan ✎ Menyebutkan gangguan yang memerlukan perhatian cepat. Tindakan : ✎ Berikan informasi dalam bentuk belajar yang bervariasi, contoh buku, program audio/ visual, Tanya jawab dll. ✎ Beri penjelasan faktor risiko, diet (Rendah lemak dan rendah garam) dan aktifitas yang berlebihan, ✎ Peringatan untuk menghindari paktfitas manuver valsava Latih pasien sehubungan dengan aktifitas yang bertahap contoh : jalan, kerja, rekreasi aktifitas seksual.
--	---



INFEKSI SALURAN KEMIH (ISK)

1. Pengertian (Definisi)	Infeksi Saluran Kemih (ISK) atau Urinarius Tractus Infection (UTI) adalah suatu keadaan adanya infasi mikroorganisme pada saluran kemih. (Agus Tessy, 2001) Infeksi Saluran Kemih (ISK) adalah suatu keadaan adanya infeksi bakteri pada saluran kemih. (Enggram, Barbara, 1998)
2. Etiologi	1. Jenis-jenis mikroorganisme yang menyebabkan ISK, antara lain: a. Escherichia Coli: 90 % penyebab ISK uncomplicated (simple) b. Pseudomonas, Proteus, Klebsiella : penyebab ISK complicated c. Enterobacter, staphylococcus epidemidis, enterococci, dan-lain-lain. 2. Prevalensi penyebab ISK pada usia lanjut, antara lain: a. Sisa urin dalam kandung kemih yang meningkat akibat pengosongan kandung kemih yang kurang efektif b. Mobilitas menurun c. Nutrisi yang sering kurang baik d. Sistem imunitas menurun, baik seluler maupun humoral e. Adanya hambatan pada aliran urin f. Hilangnya efek bakterisid dari sekresi prostat
3. Tanda dan gejala	Tanda dan gejala ISK pada bagian bawah (sistitis): – Nyeri yang sering dan rasa panas ketika berkemih – Spasme pada area kandung kemih dan suprapubis – Hematuria – Nyeri punggung dapat terjadi Tanda dan gejala ISK bagian atas (pielonefritis) – Demam – Menggigil – Nyeri panggul dan pinggang – Nyeri ketika berkemih – Malaise – Pusing – Mual dan muntah
4. Pemeriksaan penunjang	1. Urinalisis – Leukosuria atau piuria: merupakan salah satu petunjuk penting adanya ISK. Leukosuria positif bila terdapat lebih dari 5 leukosit/lapang pandang besar (LPB) sediment air kemih – Hematuria: hematuria positif bila terdapat 5-10 eritrosit/LPB sediment air kemih. Hematuria disebabkan oleh berbagai keadaan patologis baik berupa kerusakan glomerulus ataupun urolitiasis. 2. Bakteriologis – Mikroskopis – Biakan bakteri

	3. Kultur urine untuk mengidentifikasi adanya organisme spesifik 4. Hitung koloni: hitung koloni sekitar 100.000 koloni per milliliter urin dari urin tampung aliran tengah atau dari specimen dalam kateter dianggap sebagai criteria utama adanya infeksi. 5. Metode tes – Tes dipstick multistrip untuk WBC (tes esterase leukosit) dan nitrit (tes Griess untuk pengurangan nitrat). Tes esterase leukosit positif: maka pasien mengalami piuria. Tes pengurangan nitrat, Griess positif jika terdapat bakteri yang mengurangi nitrat urin normal menjadi nitrit. – Tes Penyakit Menular Seksual (PMS): Urethritis akut akibat organisme menular secara seksual (misal, klamidia trachomatis, neisseria gonorrhoeae, herpes simplek). – Tes- tes tambahan: Urogram intravena (IVU). Pielografi (IVP), sistografi, dan ultrasonografi juga dapat dilakukan untuk menentukan apakah infeksi akibat dari abnormalitas traktus urinarius, adanya batu, massa renal atau abses, hidronefrosis atau hiperplasia prostate. Urogram IV atau evaluasi ultrasonik, sistoskopi dan prosedur urodinamik dapat dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab kambuhnya infeksi yang resisten
5. Penatalaksanaan	Penanganan Infeksi Saluran Kemih (ISK) yang ideal adalah agens antibakterial yang secara efektif menghilangkan bakteri dari traktus urinarius dengan efek minimal terhadap flora fekal dan vagina. Terapi Infeksi Saluran Kemih (ISK) pada usia lanjut dapat dibedakan atas: – Terapi antibiotika dosis tunggal – Terapi antibiotika konvensional: 5-14 hari – Terapi antibiotika jangka lama: 4-6 minggu – Terapi dosis rendah untuk supresi Pemakaian antimicrobial jangka panjang menurunkan resiko kekambuhan infeksi. Jika kekambuhan disebabkan oleh bakteri persisten di awal infeksi, faktor kausatif (mis: batu, abses), jika muncul salah satu, harus segera ditangani. Setelah penanganan dan sterilisasi urin, terapi preventif dosis rendah. Penggunaan medikasi yang umum mencakup: sulfisoxazole (gastrisin), trimethoprim/sulfamethoxazole (TMP/SMZ, bactrim, septrin), kadang ampicillin atau amoksisilin digunakan, tetapi E. Coli telah resisten terhadap bakteri ini. Pyridium, suatu analgesic urinarius juga dapat digunakan untuk mengurangi ketidaknyamanan akibat infeksi. Pemakaian obat pada usia lanjut perlu dipikirkan kemungkinan adanya: – Gangguan absorpsi dalam alat pencernaan – Interaksi obat – Efek samping obat – Gangguan akumulasi obat terutama obat-obat yang ekskresinya melalui ginjal
6. Pengkajian keperawatan	1. Pemeriksaan fisik: dilakukan secara head to toe dan system tubuh 2. Riwayat atau adanya faktor-faktor resiko: – Adakah riwayat infeksi sebelumnya?

	– Adakah obstruksi pada saluran kemih? 3. Adanya factor yang menjadi predisposisi pasien terhadap infeksi nosokomial. – Bagaimana dengan pemasangan kateter foley? – Imobilisasi dalam waktu yang lama. – Apakah terjadi inkontinensia urine? 4. Pengkajian dari manifestasi klinik infeksi saluran kemih – Bagaimana pola berkemih pasien? untuk mendeteksi factor predisposisi terjadinya ISK pasien (dorongan, frekuensi, dan jumlah) – Adakah disuria? – Adakah urgensi? – Adakah hesitancy? – Adakah bau urine yang menyengat? – Bagaimana haluaran volume orine, warna (keabu-abuan) dan konsentrasi urine? – Adakah nyeri-biasanya suprapubik pada infeksi saluran kemih bagian bawah – Adakah nyeri panggul atau pinggang-biasanya pada infeksi saluran kemih bagian atas – Peningkatan suhu tubuh biasanya pada infeksi saluran kemih bagian atas. 5. Pengkajian psikologi pasien Bagaimana perasaan pasien terhadap hasil tindakan dan pengobatan yang telah dilakukan? Adakah perasaan malu atau takut kekambuhan terhadap penyakitnya.
7. Diagnosa keperawatan	a. Nyeri dan ketidaknyamanan berhubungan dengan inflamasi dan infeksi uretra, kandung kemih dan struktur traktus urinarius lain. b. Perubahan pola eliminasi berhubungan dengan obstruksi mekanik pada kandung kemih ataupun struktur traktus urinarius lain. c. Kurangnya pengetahuan tentang kondisi, prognosis, dan kebutuhan pengobatan berhubungan dengan kurangnya sumber informasi.
8. Intervensi keperawatan	1. Dx 1 : Nyeri dan ketidaknyamanan berhubungan dengan inflamasi dan infeksi uretra, kandung kemih dan struktur traktus urinarius lain. Kriteria evaluasi: Tidak nyeri waktu berkemih, tidak nyeri pada perkusi panggul Intervensi: a. Pantau haluaran urine terhadap perubahan warna, bau dan pola berkemih, masukan dan haluaran setiap 8 jam dan pantau hasil urinalisis ulang Rasional: untuk mengidentifikasi indikasi kemajuan atau penyimpangan dari hasil yang diharapkan b. Catat lokasi, lamanya intensitas skala (1-10) penyebaran nyeri. Rasional: membantu mengevaluasi tempat obstruksi dan penyebab nyeri c. Berikan tindakan nyaman, seperti pijatan punggung, lingkungan istirahat; Rasional: meningkatkan relaksasi, menurunkan tegangan otot. d. Bantu atau dorong penggunaan nafas berfokus

	Relaksasi: membantu mengarahkan kembali perhatian dan untuk relaksasi otot. e. Berikan perawatan perineal Rasional: untuk mencegah kontaminasi uretra f. Jika dipaang kateter indwelling, berikan perawatan kateter 2 nkali per hari. Rasional: Kateter memberikan jalan bakteri untuk memasuki kandung kemih dan naik ke saluran perkemihan. g. Kolaborasi: – Konsul dokter bila: sebelumnya kuning gading-urine kuning, jingga gelap, berkabut atau keruh. Pla berkemih berubah, sring berkemih dengan jumlah sedikit, perasaan ingin kencing, menetes setelah berkemih. Nyeri menetap atau bertambah sakit Rasional: Temuan- temuan ini dapat memeberi tanda kerusakan jaringan lanjut dan perlu pemeriksaan luas – Berikan analgesic sesuia kebutuhan dan evaluasi keberhasilannya Rasional: analgesic memblok lintasan nyeri sehingga mengurangi nyeri h. Berikan antibiotic. Buat berbagai variasi sediaan minum, termasuk air segar. Pemberian air sampai 2400 ml/hari Rasional: akibta dari haluaran urin memudahkan berkemih sering dan membantu membilas saluran berkemih 2. Dx 2: Perubahan pola eliminasi berhubungan dengan obstruksi mekanik pada kandung kemih ataupun struktur traktus urinarius lain. Kriteria Evaluasi: Pola eliminasi membaik, tidak terjadi tanda-tanda gangguan berkemih (urgensi, oliguri, disuria) Intervensi: a. Awasi pemasukan dan pengeluaran karakteristi urin Rasional: memberikan informasi tentang fungsi ginjal dan adanya komplikasi b. Tentukan pola berkemih pasien c. Dorong meningkatkan pemasukan cairan Rasional: peningkatan hidrasi membilas bakteri. d. Kaji keluhan kandung kemih penuh Rasional: retensi urin dapat terjadi menyebabkan distensi jaringan (kandung kemih/ginjal) e. Observasi perubahan status mental: perilaku atau tingkat kesadaran Rasional: akumulasi sisa uremik dan ketidakseimbangan elektrolit dapat menjadi toksik pada susunan saraf pusat f. Kecuali dikontraindikasikan: ubah posisi pasien setiap dua jam Rasional: untuk mencegah statis urin g. Kolaborasi: – Awasi pemeriksaan laboratorium; elektrolit, BUN, kreatinin Rasional: pengawasan terhadap disfungsi ginjal
--	---

	– Lakukan tindakan untuk memelihara asam urin: tingkatkan masukan sari buah beri dan berikan obat-obat untuk meningkatkan asam urin. Rasional: asam urin menghalangi tumbuhnya kuman. Peningkatan masukan sari buah dapat berpengaruh dalam pengobatan infeksi saluran kemih. 3. Dx 3: Kurangnya pengetahuan tentang kondisi, prognosis, dan kebutuhan pengobatan berhubungan dengan kurangnya sumber informasi. Kriteria Evaluasi: menyatakan mengerti tentang kondisi, pemeriksaan diagnostic, rencana pengobatan, dan tindakan perawatan diri preventif. Intervensi: a. Kaji ulang proses penyakit dan harapan yang akan datang Rasional: memberikan pengetahuan dasar dimana pasien dapat membuat pilihan berdasarkan informasi. b. Berikan informasi tentang: sumber infeksi, tindakan untuk mencegah penyebaran, jelaskan pemberian antibiotik, pemeriksaan diagnostic: tujuan, gambaran singkat, persiapan yang dibutuhkan sebelum pemeriksaan, perawatan sesudah pemeriksaan. Rasional: pengetahuan apa yang diharapkan dapat mengurangi ansietas dan membantu mengembangkan kepatuhan klien terhadap rencana terapeutik. c. Pastikan pasien atau orang terdekat telah menulis perjanjian untuk perawatan lanjut dan instruksi tertulis untuk perawatan sesudah pemeriksaan Rasional: instruksi verbal dapat dengan mudah dilupakan d. Instruksikan pasien untuk menggunakan obat yang diberikan, minum sebanyak kurang lebih delapan gelas per hari khususnya sari buah beri. Rasional: Pasien sering menghentikan obat mereka, jika tanda-tanda penyakit mereda. Cairan menolong membilas ginjal. Asam piruvat dari sari buah beri membantu mempertahankan keadaan asam urin dan mencegah pertumbuhan bakteri e. Berikan kesempatan kepada pasien untuk mengekspresikan perasaan dan masalah tentang rencana pengobatan. Rasional: Untuk mendeteksi isyarat indikatif kemungkinan ketidakpatuhan dan membantu mengembangkan penerimaan rencana terapeutik.
--	---



LOW BACK PAIN (LBP)

1. Pengertian (Definisi)	Nyeri adalah pengalaman sensori dan emosional yang tidak menyenangkan akibat dari kerusakan jaringan yang actual maupun potensial. Definisi keperawatan tentang nyeri adalah, apapun yang menyakitkan tubuh yang dikatakan individu/seseorang yang mengalaminya, yang ada kapanpun orang tersebut mengatakannya. Peraturan utama dalam merawat pasien dengan nyeri adalah bahwa semua nyeri adalah nyata, meskipun penyebabnya tidak diketahui. Oleh karena itu, keberadaan nyeri adalah berdasarkan hanya pada laporan pasien. Low Back Pain (LBP) atau Nyeri punggung bawah adalah suatu sensasi nyeri yang dirasakan pada diskus intervertebralis umumnya lumbal bawah, L4-L5 dan L5-S1.
2. Etiologi	Kebanyakan nyeri punggung bawah disebabkan oleh salah satu dari berbagai masalah muskuloskeletal (misal regangan lumbosakral akut, ketidakstabilan ligamen lumbosakral dan kelemahan otot, osteoarthritis tulang belakang, stenosis tulang belakang, masalah diskus intervertebralis, ketidakseimbangan panjang tungkai). Penyebab lainnya meliputi obesitas, gangguan ginjal, masalah pelvis, tumor retroperitoneal, aneurisma abdominal dan masalah psikosomatik. Kebanyakan nyeri punggung akibat gangguan muskuloskeletal akan diperberat oleh aktifitas, sedangkan nyeri akibat keadaan lainnya tidak dipengaruhi oleh aktifitas.
3. Tanda dan gejala	Rasa nyeri bahkan nyeri hebat pada punggung bagian bawah.
4. Pemeriksaan penunjang	Prosedur diagnostik perlu dilakukan pada pasien yang menderita nyeri punggung bawah. Sinar X- vertebra mungkin memperlihatkan adanya fraktur, dislokasi, infeksi, osteoarthritis atau scoliosis. Computed Tomografi (CT) berguna untuk mengetahui penyakit yang mendasari, seperti adanya lesi jaringan lunak tersembunyi disekitar kolumna vertebralis dan masalah diskus intervertebralis. USG dapat membantu mendiagnosa penyempitan kanalis spinalis. MRI memungkinkan visualisasi sifat dan lokasi patologi tulang belakang.
5. Pengkajian keperawatan	Pasien nyeri punggung dibimbing untuk menjelaskan ketidaknyamanannya (misal lokasi, berat, durasi, sifat, penjaran dan kelemahan tungkai yang berhubungan). Penjelasan mengenai bagaimana nyeri timbul dengan tindakan tertentu atau dengan aktifitas dimana otot yang lemah digunakan secara berlebihan dan bagaimana pasien mengatasinya. Informasi mengenai pekerjaan dan aktifitas rekreasi dapat membantu mengidentifikasi area untuk pendidikan kesehatan. Selama wawancara ini, perawat dapat melakukan observasi terhadap postur pasien, kelainan posisi dan cara jalan. Pada pemeriksaan fisik, dikaji lengkungan tulang belakang, Krista iliakan dan kesimetrisan bahu. Otot paraspinal dipalpasi dan dicatat adanya spasme

	dan nyeri tekan. Pasien dikaji adanya obesitas karena dapat menimbulkan nyeri punggung bawah.
6. Diagnosa dan intervensi keperawatan	1. Nyeri b.d masalah muskuloskeletal Intervensi: Meredakan nyeri Untuk mengurangi nyeri perawat dapat menganjurkan tirah baring dan perubahan posisi yang ditentukan untuk memperbaiki fleksi lumbal. Pasien diajari untuk mengontrol dan menyesuaikan nyeri yang dilakukan melalui pernafasan diafragma dan relaksasi dapat membantu mengurangi tegangan otot yang berperan pada nyeri punggung bawah. Mengalihkan perhatian pasien dari nyeri dengan aktifitas lain misal membaca buku, menonton TV maupun dengan imajinasi (membayangkan hal-hal yang menyenangkan dengan memusatkan perhatian pada hal tersebut). Masase jaringan lunak dengan lembut sangat berguna untuk mengurangi spasme otot, memperbaiki peredaran darah dan mengurangi pembendungan serta mengurangi nyeri. Bila diberikan obat perawat harus mengkaji respon pasien pada setiap obat. 2. Kerusakan mobilitas fisik b.d nyeri, spasme otot, dan berkurangnya kelenturan Intervensi: - Memperbaiki mobilitas fisik Mobilitas fisik dipantau melalui pengkajian kontinu. Perawat mengkaji bagaimana pasien bergerak dan berdiri. Begitu nyeri punggung berkurang, aktifitas perawatan diri boleh dilakukan dengan regangan yang minimal pada struktur yang cedera. Perubahan posisi harus dilakukan perlahan dan dibantu bila perlu. Gerakan memutar dan melenggok perlu dihindari. Pasien didorong untuk berganti-ganti aktifitas berbaring, duduk dan berjalan-jalan dalam waktu lama. Perawat perlu mendorong pasien mematuhi program latihan sesuai yang ditetapkan, latihan yang salah justru tidak efektif. - Meningkatkan mekanika tubuh yang tepat. Pasien harus diajari bagaimana duduk, berdiri, berbaring dan mengangkat barang dengan benar. 3. Kurang pengetahuan b.d teknik mekanika tubuh melindungi punggung Intervensi: Pendidikan kesehatan Pasien harus diajari bagaimana duduk, berdiri, berbaring dan mengangkat barang dengan benar 4. Perubahan kinerja peran b.d gangguan mobilitas dan nyeri kronik 5. Gangguan nutrisi : lebih dari kebutuhan tubuh b. d obesitas Intervensi: - Memperbaiki kinerja peran Tanggung jawab yang berhubungan dengan peran mungkin telah berubah sejak terjadinya nyeri punggung bawah. Begitu nyeri sembuh, pasien dapat kembali ke tanggung jawab perannya lagi. Namun bila aktifitas ini berpengaruh terhadap terjadinya nyeri punggung bawah lagi, mungkin sulit untuk kembali ke tanggung jawab semula tersebut tanpa menanggung resiko terjadinya nyeri punggung bawah kronik dengan kecacatan dan depresi yang diakibatkan. - Mengubah nutrisi dan penurunan berat badan

	Penurunan BB melalui penyesuaian cara makan dapat mencegah kekambuhan nyeri punggung, dengan melalui rencana nutrisi yang rasional yang meliputi perubahan kebiasaan makan untuk mempertahankan BB yang diinginkan.
--	--

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SAHABAT MENUJU SEHAT	ASUHAN KEPERAWATAN RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA TAHUN 2025
---	--

THIROID	
1. Pengertian (Definisi)	Demam tifoid adalah penyakit tidak menular yang bersifat akut, yang ditandai dengan bakterimia, perubahan pada sistem retikuloendotelial yang bersifat difus, pembentukan mikroabses dan ulserasi Nodus peyer di distal ileum. (Soegeng Soegijanto, 2002) Tifus abdominalis adalah suatu infeksi sistem yang ditandai demam, sakit kepala, kelesuan, anoreksia, bradikardi relatif, kadang-kadang pembesaran dari limpa/hati/kedua-duanya. (Samsuridjal D dan heru S, 2003)
2. Etiologi	Salmonella typhi yang menyebabkan infeksi invasif yang ditandai oleh demam, toksemia, nyeri perut, konstipasi/diare. Komplikasi yang dapat terjadi antara lain: perforasi usus, perdarahan, toksemia dan kematian. (Ranuh, Hariyono, dan dkk. 2001) Etiologi demam tifoid dan demam paratipoid adalah S.typhi, S.paratyphi A, S.paratyphi b dan S.paratyphi C. (Arjatmo Tjokronegoro, 1997)
3. Tanda dan gejala	Gejala klinis pada anak umumnya lebih ringan dan lebih bervariasi dibandingkan dengan orang dewasa. Walaupun gejala demam tifoid pada anak lebih bervariasi, tetapi secara garis besar terdiri dari demam satu minggu/lebih, terdapat gangguan saluran pencernaan dan gangguan kesadaran. Dalam minggu pertama, keluhan dan gejala menyerupai penyakit infeksi akut pada umumnya seperti demam, nyeri kepala, anoreksia, mual, muntah, diare, konstipasi, serta suhu badan yang meningkat. Pada minggu kedua maka gejala/tanda klinis menjadi makin jelas, berupa demam remiten, lidah tifoid, pembesaran hati dan limpa, perut kembung, bisa disertai gangguan kesadaran dari ringan sampai berat. Lidah tifoid dan tampak kering, dilapisi selaput kecoklatan yang tebal, di bagian ujung tepi tampak lebih kemerahan. (Ranuh, Hariyono, dan dkk. 2001) Sejalan dengan perkembangan penyakit, suhu tubuh meningkat dengan gambaran 'anak tangga'. Menjelang akhir minggu pertama, pasien menjadi bertambah toksik. (Vanda Joss & Stephen Rose, 1997)
4. Pemeriksaan penunjang	1. Pemeriksaan Darah Perifer Lengkap Dapat ditemukan leukopeni, dapat pula leukositosis atau kadar leukosit normal. Leukositosis dapat terjadi walaupun tanpa disertai infeksi sekunder. 2. Pemeriksaan SGOT dan SGPT SGOT dan SGPT sering meningkat, tetapi akan kembali normal setelah sembuh. Peningkatan SGOT dan SGPT ini tidak memerlukan penanganan khusus 3. Pemeriksaan Uji Widal Uji Widal dilakukan untuk mendeteksi adanya antibodi terhadap bakteri Salmonella typhi. Uji Widal dimaksudkan untuk menentukan adanya aglutinin dalam serum penderita Demam Tifoid. Akibat adanya infeksi oleh Salmonella typhi maka penderita membuat antibodi (aglutinin) yaitu:

	• Aglutinin O: karena rangsangan antigen O yang berasal dari tubuh bakteri • Aglutinin H: karena rangsangan antigen H yang berasal dari flagela bakteri • Aglutinin Vi: karena rangsangan antigen Vi yang berasal dari simpai bakter. Dari ketiga aglutinin tersebut hanya aglutinin O dan H yang digunakan untuk diagnosis Demam Tifoid. Semakin tinggi titernya semakin besar kemungkinan menderita Demam Tifoid. (Widiastuti Samekto, 2001)
5. Pengkajian keperawatan	- Riwayat keperawatan - Kaji adanya gejala dan tanda meningkatnya suhu tubuh terutama pada malam hari, nyeri kepala, lidah kotor, tidak nafsu makan, epistaksis, penurunan kesadaran
6. Diagnosa dan intervensi keperawatan	1. Hipertermi berhubungan dengan proses infeksi Tujuan: Mempertahankan suhu dalam batas normal • Kaji pengetahuan klien dan keluarga tentang hipertermia • Observasi suhu, nadi, tekanan darah, pernafasan • Beri minum yang cukup • Berikan kompres air biasa • Lakukan tepid sponge (seka) • Pakaian (baju) yang tipis dan menyerap keringat • Pemberian obat antipireksia • Pemberian cairan parenteral (IV) yang adekuat 2. Perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan tidak ada nafsu makan, mual, dan kembung Tujuan: Meningkatkan kebutuhan nutrisi dan cairan • Menilai status nutrisi anak • Ijinkan anak untuk memakan makanan yang dapat ditoleransi anak, rencanakan untuk memperbaiki kualitas gizi pada saat selera makan anak meningkat. • Berikan makanan yang disertai dengan suplemen nutrisi untuk meningkatkan kualitas intake nutrisi • Menganjurkan kepada orang tua untuk memberikan makanan dengan teknik porsi kecil tetapi sering • Menimbang berat badan setiap hari pada waktu yang sama, dan dengan skala yang sama • Mempertahankan kebersihan mulut anak • Menjelaskan pentingnya intake nutrisi yang adekuat untuk penyembuhan penyakit • Kolaborasi untuk pemberian makanan melalui parenteral jika pemberian makanan melalui oral tidak memenuhi kebutuhan gizi anak 3. Risiko kurangnya volume cairan berhubungan dengan kurangnya intake cairan, dan peningkatan suhu tubuh Tujuan: Mencegah kurangnya volume cairan • Mengobservasi tanda-tanda vital (suhu tubuh) paling sedikit setiap 4 jam

	• Monitor tanda-tanda meningkatnya kekurangan cairan: turgor tidak elastis, ubun-ubun cekung, produksi urin menurun, memberan mukosa kering, bibir pecah-pecah • Mengobservasi dan mencatat berat badan pada waktu yang sama dan dengan skala yang sama • Memonitor pemberian cairan melalui intravena setiap jam • Mengurangi kehilangan cairan yang tidak terlihat (Insensible Water Loss/IWL) dengan memberikan kompres dingin atau dengan tepid sponge • Memberikan antibiotik sesuai program
--	---

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SAHABAT MENUJU SEHAT	ASUHAN KEPERAWATAN RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA TAHUN 2025
---	--

TONSILITIS	
1. Pengertian (Definisi)	Tonsilitis akut adalah peradangan pada tonsil yang masih bersifat ringan. Radang tonsil pada anak hampir selalu melibatkan organ sekitarnya sehingga infeksi pada faring biasanya juga mengenai tonsil sehingga disebut sebagai tonsilofaringitis. (Ngastiyah,1997)
2. Etiologi	Penyebab tonsilitis bermacam – macam, diantaranya adalah yangtersebut dibawah ini yaitu : 1. Streptokokus Beta Hemolitikus 2. Streptokokus Viridans 3. Streptokokus Piogenes 4. Virus Influenza Infeksi ini menular melalui kontak dari sekret hidung dan ludah (<i>droplet infections</i>)
3. Tanda dan gejala	Tanda dan gejala tonsilitis akut adalah : 1. nyeri tenggorok 2. nyeri telan 3. sulit menelan 4. demam 5. mual 6. anoreksia 7. kelenjar limfa leher membesar 8. faring hiperemis 9. edema faring 10. pembesaran tonsil 11. tonsil hiperemia 12. mulut berbau 13. otalgia (sakit di telinga) 14. malaise
4. Pemeriksaan penunjang	Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan untuk memperkuat diagnosa tonsilitis akut adalah pemeriksaan laboratorium meliputi : 1. Leukosit: terjadi peningkatan 2. Hemoglobin: terjadi penurunan 3. Usap tonsil untuk pemeriksaan kultur bakteri dan tes sensitifitas obat
5. Pengkajian keperawatan	1. Keluhan utama : sakit tenggorokan, nyeri telan, demam dll 2. Riwayat penyakit sekarang : serangan, karakteristik, insiden, perkembangan, efek terapi dll 3. Riwayat kesehatan lalu – riwayat kelahiran – riwayat imunisasi – penyakit yang pernah diderita (faringitis berulang, ISPA, otitis media) – riwayat hospitalisasi 4. Pengkajian umum: usia, tingkat kesadaran, antropometri, tanda – tanda vital dll 5. Pernafasan: kesulitan bernafas, batuk 6. Ukuran besarnya tonsil dinyatakan dengan : • T0 : bila sudah dioperasi • T1 : ukuran yang normal ada • T2 : pembesaran tonsil tidak sampai garis tengah

	• T3 : pembesaran mencapai garis tengah • T4 : pembesaran melewati garis tengah 7. Nutrisi: sakit tenggorokan, nyeri telan, nafsu makan menurun, menolak makan dan minum, turgor kurang 8. Aktivitas / istirahat: anak tampak lemah, letargi, iritabel, malaise 9. Keamanan / kenyamanan: kecemasan anak terhadap hospitalisasi
6. Diagnosa dan intervensi keperawatan	1. Hipertermi berhubungan dengan proses inflamasi pada tonsil Intervensi : • Pantau suhu tubuh anak (derajat dan pola), perhatikan menggigil atau tidak • Pantau suhu lingkungan • Batasi penggunaan linen, pakaian yang dikenakan klien • Berikan kompres hangat • Berikan cairan yang banyak (1500 – 2000 cc/hari) • Kolaborasi pemberian antipiretik 2. Nyeri berhubungan dengan pembengkakan pada tonsil Intervensi : • Pantau nyeri klien(skala, intensitas, kedalaman, frekuensi) • Kaji TTV • Berikan posisi yang nyaman • Berikan tehnik relaksasi dengan tarik nafas panjang melalui hidung dan mengeluarkannya pelan – pelan melalui mulut • Berikan tehnik distraksi untuk mengalihkan perhatian anak • Kolaborasi pemberian analgetik 3. Resiko perubahan status nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan adanya anoreksia Intervensi : • Kaji conjungtiva, sclera, turgor kulit • Timbang BB tiap hari • Berikan makanan dalam keadaan hangat • Berikan makanan dalam porsi sedikit tapi seringsajikan makanan dalam bentuk yang menarik • Tingkatkan kenyamanan lingkungan saat makan • Kolaborasi pemberian vitamin penambah nafsu makan 4. Intoleransi aktifitas berhubungan dengan kelemahan Intervensi : • Kaji kemampuan klien dalam melakukan aktifitas • Observasi adanya kelelahan dalam melakukan aktifitas • Monitor TTV sebelum, selama dan sesudah melakukan aktifitas • Berikan lingkungan yang tenang • Tingkatkan aktifitas sesuai toleransi klien 5. Gangguan persepsi sensori : pendengaran berhubungan dengan adanya obstruksi pada tuba eustakii. Intervensi : • Kaji ulang gangguan pendengaran yang dialami klien • Lakukan irigasi telinga • Berbicaralah dengan jelas dan pelan

	• Gunakan papan tulis / kertas untuk berkomunikasi jika terdapat kesulitan dalam berkomunikasi • Kolaborasi pemeriksaan audiometri • Kolaborasi pemberian tetes telinga
--	---



TUMOR OTAK

1. Pengertian (Definisi)	Tumor otak adalah lesi intra kranial yang menempati ruang dalam tulang tengkorak
2. Etiologi	1. Tumor yang berasal dari lapisam otak (meningioma dural) 2. Tumor yang berkembang didalam / pada syaraf kranial 3. Tumor yang berasal didalam jaringan otak 4. Lesi metastatik yang berasal dari bagian tubuh mana saja
3. Tanda dan gejala	Menurut lokasi tumor : 1. Lobus frontalis Gangguan mental / gangguan kepribadian ringan : depresi, bingung, tingkah laku aneh, sulit memberi argumen/ menilai benar atau tidak, hemiparesis, ataksia, dan gangguan bicara. 2. Kortek presentalis posterior Kelemahan/kelumpuhan pada otot-otot wajah, lidah dan jari 3. Lobus parasentris Kelemahan pada ekstremitas bawah 4. Lobus Oksipitalis Kejang, gangguan penglihatan 5. Lobus temporalis Tinitus, halusinasi pendengaran, afasia sensorik, kelumpuhan otot wajah 6. Lobus Parietalis Hilang fungsi sensorik, kortikalis, gangguan lokalisasi sensorik, gangguan penglihatan 7. Cerebulum Papil oedema, nyeri kepala, gangguan motorik, hipotonia, hiperekstremitas esndi Tanda dan Gejala Umum : 1. Nyeri kepala berat pada pagi hari, main bertambah bila batuk, membungkuk 2. Kejang 3. Tanda-tanda peningkatan tekanan intra kranial : Pandangan kabur, mual, muntah, penurunan fungsi pendengaran, perubahan tanda-tanda vital, afasia. 4. Perubahan kepribadian 5. Gangguan memori 6. Gangguan alam perasaan Trias Klasik ; - Nyeri kepala - Papil oedema - Muntah

4. Pemeriksaan penunjang	1. Rontgent tengkorak anterior-posterior 2. EEG 3. CT Scan 4. MRI 5. Angioserebral
5. Pengkajian keperawatan	1. Data klien : nama, umur, jenis kelamin, agama, suku bangsa, status perkawinan, pendidikan, pekerjaan, golongan darah, penghasilan, alamat, penanggung jawab, dll 2. Riwayat kesehatan : - keluhan utama - Riwayat kesehatan sekarang - Riwayat Kesehatan lalu - Riwayat Kesehatan Keluarga 3. Pemeriksaan fisik : • Saraf : kejang, tingkah laku aneh, disorientasi, afasia, penurunan/kehilangan memori, afek tidak sesuai, berdesis • Penglihatan : penurunan lapang pandang, penglihatan kabur • Pendneganan : tinitus, penurunan pendengaran, halusinasi • Jantung : bradikardi, hipertensi • Sistem pernafasan : irama nafas meningkat, dispnea, potensial obstruksi jalan nafas, disfungsi neuromuskuler • Sistem hormonal : amenorea, rambut rontok, diabetes melitus • Motorik : hiperekstensi, kelemahan sendi
6. Diagnosa keperawatan dan intervensi	1. Gangguan pertukaran gas b.d disfungsi neuromuskuler (hilangnya kontrol terhadap otot pernafasan), ditandai dengan : perubahan kedalaman nafasn, dispnea, obstruksi jalan nafas, aspirasi. Tujuan : Gangguan pertukaran gas dapat teratasi Tindakan : - Bebaskan jalan nafas - Pantau vital sign - Monitor pola nafas, bunyi nafas - Pantau AGD - Monitor penurunan gas darah - Kolaborasi O2 2. Gangguan rasa nyaman, nyer kepla b.d peningkatan TIK, ditndai dengan : nyeri kepala terutama pagi hari, klien merintih kesakitan, nyeri bertambah bila klien batuk, mengejan, membungkuk Tujuan : rasa nyeri berkurang Tindakan : - pantau skala nyeri - Berikan kompres dimana pada area yang sakit - Monitor tanda vital - Beri posisi yang nyaman - Lakukan Massage - Observasi tanda nyeri non verbal - Kaji faktor defisid, emosi dari keadaan seseorang - Catat adanya pengaruh nyeri - Kompres dingin pada daerah kepala - Gunakan teknik sentuham yang terapeutik

	- Observasi mual, muntah - Kolaborasi pemberian obat : analgetik, relaksan, prednison, antiemetic 3. Resiko tinggi cedera b.d disfungsi otot sekunder terhadap depresi SSP, ditandai dengan : kejang, disorientasi, gangguan penglihatan, pendengaran Tujuan : tidak terjadi cedera Tindakan : - Identifikasi bahaya potensial pada lingkungan klien - Pantau tingkat kesadaran - Orientasikan klien pada tempat, orang, waktu, kejadian - Observasi saat kejang, lama kejang, antikonvulsi, - Anjurkan klien untuk tidak beraktifitas 4. Perubahan proses pikir b.d perubahan fisiologi, ditandai dengan disorientasi, penurunan kesadaran, sulit konsentrasi Tujuan : mempertahankan orientasi mental dan realitas budaya Tindakan : - kaji rentang perhatian - Pastikan keluarga untuk membandingkan kepribadian sebelum mengalami trauma dengan respon klien sekarang - Pertahankan bantuan yang konsisten oleh staf, keberadaan staf sebanyak mungkin - Jelaskan pentingnya pemeriksaan neurologis - Kurangi stimulus yang merangsang, kritik yang negatif - Dengarkan klien dengan penuh perhatian semua hal yang diungkapkan klien/keluarga - Instruksikan untuk melakukan rileksasi - Hindari meninggalkan klien sendiri 5. Gangguan perfusi serebral b.d hipoksia jaringan, ditandai dengan peningkatan TIK, nekrosis jaringan, pembengkakan jaringan otak, depresi SSP dan oedema Tujuan : gangguan perfusi jaringan berkurang/hilang Tindakan : - Tentukan faktor yang berhubungan dengan keadaan tertentu, yang dapat menyebabkan penurunan perfusi dan potensial peningkatan TIK - Catat status neurologi secara teratur, bandingkan dengan nilai standart - Kaji respon motorik terhadap perintah sederhana - Pantau tekanan darah - Evaluasi : pupil, keadaan pupil, catat ukuran pupil, ketajaman penglihatan dan penglihatan kabur - Pantau suhu lingkungan - Pantau intake, output, turgor - Beritahu klien untuk menghindari/ membatasi batuk, untah - Perhatikan adanya gelisah meningkat, tingkah laku yang tidak sesuai - Tinggikan kepala 15-45 derajat 6. Cemas b.d kurang informasi tentang prosedur
--	--

	Tujuan : rasa cemas berkuang Tindakan : - kaji status mental dan tingkat cemas - Beri penjelasan hubungan antara proses penyakit dan gejala - Jawab setiap pertanyaan dengan penuh perhatian - Beri kesempatan klien untuk mengungkapkan piiran dan perasaan takut - Libatkan keluarga dalam perawatan
--	--

Ditetapkan di Malang
 Pada tanggal 05 Agustus 2025
 Direktur Rumah Sakit Prima Husada,



dr. Nur Mazidah